IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Acompañamiento Terapéutico

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

AUTORIDADES

Rectora: Prof. Silvia Adaro

Vice Rectora Prof. Andrea Noelia Fabiana Vaquera.

Secretario Académica: Prof. Santiago Garcia

Secretaria Administrativa: Prof. Marta Mamani

COLABORADORES:

Profesora ALANCAY NANCY

Profesora BURGOS ALICIA

Acompañante Terapéutica Integral RIVERO DAIANA G.

Acompañante Terapéutica Integral VARGAS LUCIANA DEL VALLE

COORDINACIÓN DE LA CARRERA:

Lic. y Prof. GLADIS NOEMÍ MAMANI

PALABRAS DE BIENVENIDA

Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal.
Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía y busco para mi propia gloria la senda más angosta y más difícil. ¿Es eso, de tonto o mentecato?

Miguel de Cervantes Saavedra, DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Queridos y queridas estudiantes:

Hoy comienzan un viaje que marcará sus vidas. Un camino lleno de aprendizajes, desafíos y, sobre todo, humanidad. Quiero agradecerles profundamente por confiar en esta institución, en sus docentes, y, más importante aún, en ustedes mismos. Decidir recorrer este sendero es un acto valiente que refleja su compromiso con los demás y con sus propios sueños.

Les damos la bienvenida a la carrera de Acompañamiento Terapéutico, una práctica y una profesión que, en la Argentina, tiene una historia profundamente ligada a los procesos de transformación de la salud mental, a la defensa de los derechos y a la construcción de dispositivos alternativos a la exclusión y al encierro.

Como Don Quijote, el Acompañante Terapéutico elige caminar por senderos poco transitados, por espacios donde el padecimiento se vuelve cotidiano, donde los diagnósticos muchas veces no alcanzan para explicar el sufrimiento y donde el lazo con el otro se vuelve frágil o amenazado. Lejos de la comodidad de respuestas rápidas o soluciones estandarizadas, el AT se compromete con una clínica situada, artesanal, construida caso por caso.

En nuestro país, el Acompañamiento Terapéutico surge y se desarrolla en diálogo con el psicoanálisis, la psicología social, la clínica vincular y comunitaria, y los movimientos de reforma en salud mental. Es una práctica que se inscribe en la vida cotidiana, en los territorios, en las casas, las escuelas, los hospitales, las comunidades. Una clínica en

movimiento, como la define Rossi, que se sostiene en red y en equipo, y que apuesta a la inclusión allí donde la sociedad muchas veces expulsa.

Ser Acompañante Terapéutico en la Argentina no es solo ejercer una función técnica, sino asumir una posición ética y política: reconocer al otro como sujeto de derechos, resistir las lógicas de segregación, y sostener la singularidad frente a modelos que tienden a homogeneizar y clasificar. Es, en muchos sentidos, "deshacer entuertos" en lo cotidiano: alojar, escuchar, acompañar, poner palabras donde hay silencio, y presencia donde hubo abandono.

Como en la figura quijotesca, esta elección puede parecer, para algunos, ingenua o excesivamente idealista. Sin embargo, la historia del AT en nuestro país demuestra que lejos de la locura, hay en esta práctica una profunda lucidez clínica: la de comprender que el sufrimiento psíquico no se resuelve sin lazo, sin otro, sin comunidad.

A lo largo de esta formación, los y las invitamos a apropiarse de una tradición clínica argentina comprometida, crítica y en permanente construcción. Una formación que articula teoría y práctica, que valora el trabajo interdisciplinario y que entiende que el vínculo es la principal herramienta del Acompañante Terapéutico.

Elegir esta carrera es elegir la senda más angosta y, muchas veces, la más difícil. Pero también es elegir una profesión que apuesta a la humanización, a la presencia y al cuidado en un tiempo marcado por la fragmentación y la prisa.

Sean bienvenidas y bienvenidos al Acompañamiento Terapéutico.
Una práctica profundamente argentina, profundamente humana

Lic. Prof.: Mamani, Gladis Noemí

Coordinadora I.E.S. Nº11

EL CURSO DE INGRESO 2026

El Curso de Ingreso 2026 constituye un espacio de primer acercamiento a la carrera y tiene como finalidad orientar y acompañar a los aspirantes en las exigencias del nuevo escenario de aprendizaje que implica la educación superior, promoviendo el desarrollo de sus potencialidades y creando un espacio de reflexión que les permita conocer un poco más de lo que significa estudiar en el IES Nº 11 y de los requerimientos de la carrera elegida.

Es importante que cada aspirante sea protagonista de sus aprendizajes, siendo necesaria su participación activa, crítica y responsable en este proceso para favorecer su ingreso y permanencia en la carrera elegida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE INGRESO 2026

- Generar instancias para el conocimiento de los principales aspectos que caracterizan la vida institucional, compartiendo el ideario basado en la síntesis fe, ciencia y cultura.
- Ofrecer un acercamiento teórico básico al objeto de estudio de cada carrera.
- Orientar al aspirante en el abordaje de las características distintivas de la carrera en la que se inscribe, poniendo énfasis en el perfil y oficio del estudiante del nivel superior.

FECHAS DEL CURSO DE INGRESO

Desarrollo de Contenidos del Curso de Ingreso.	**Actividad bimodal: Presencial/ Virtual**
Inicio	**25 de Febrero 2026**
Finalización	**13 de Marzo 2026**
Primera instancia presentación	**Modalidad Presencial del 25 al 27 de Febrero**
Dictado del Cursillo	**Del 2 al 13 de Marzo 2026** **Modalidad: Bimodal (Presencial- Virtual).**
Evaluación del cursillo	**Del 16 al 19 de Marzo 2026** **Modalidad: Presencial Formulario de Google.**

FECHA DE CURSO DE INGRESO 2026

FECHA	HORARIO	EJE	DOCENTES RESPONSABLES	MODALIDAD
25/02/2026	15 a 17 hs	Bienvenida, presentación institucional e integración	**Mamani Gladis – Luciana Vargas – Daiana**	Presencial
02/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 1**	**Pascale Leila – Alancay Nancy**	A confirmar
03/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 2**	Caceres Hugo- Valencia Claudia	A confirmar
04/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 3**	Santos Gisela- Mamani Alicia-	A confirmar
05/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 4**	Garzon Nora- Aguirre Beatriz- Lopez Eduardo	A confirmar
06/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 4 (continuidad)**	Garzon Nora- Aguirre Beatriz- Lopez Eduardo	A confirmar
09/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 5**	Mamani Gladis- Vargas Luciana- Rivero Daiana	A confirmar
10/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 5 (continuidad)**	Mamani Gladis- Vargas Luciana- Rivero Daiana	A confirmar
11/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 6**	**Burgos Alicia- Saiquita Flavia**	A confirmar
12/03/2026	15 a 17 hs	**EJE 6 (continuidad)**	**Burgos Alicia- Saiquita Flavia**	A confirmar
13/03/2026	15 a 17 hs	**Integración final**		Virtual
19/03/2026	15 a 17 hs	**EXAMEN FINAL**	**EQUIPO DOCENTE**	PRESENCIAL

INFORMACION IMPORTATE

Clases sincrónicas

Las clases sincrónicas se realizarán a través del enlace que será enviado al **aula virtual** correspondiente.
Se solicita **puntualidad**, debiendo ingresar a la plataforma **20 minutos antes del inicio de la clase**, a fin de asegurar el correcto registro de asistencia. Para facilitar la identificación, se recomienda ingresar a **Google Meet o Zoom con nombre y apellido**.

En el aula virtual se encontrará disponible material de lectura, videos, actividades prácticas, test de autoevaluación y/o tareas, todas ellas con fechas de entrega previamente establecidas.
Estas instancias forman parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Evaluación

- Es **fundamental** que el/la aspirante **realice la lectura y el estudio de la cartilla** antes de asistir al cursillo de ingreso.
- El **Examen de Ingreso – Modalidad Presencial** se llevará a cabo el día
  MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 2026, en la institución.
  Horario 15 a 17 hs

EJE 1:

SER ESTUDIANTE DEL NIVEL SUPERIOR

Todo viaje comienza con un primer paso. Don Quijote lo dio al salir de su casa, decidido a enfrentar un mundo desconocido con convicción y propósito. Del mismo modo, iniciar una carrera en el Nivel Superior implica atravesar un umbral: dejar atrás certezas conocidas para ingresar en una nueva forma de habitar el estudio, el tiempo y el compromiso con el saber.

Este eje invita a conocer el I.E.S. Nº 11 como territorio de formación, encuentro y construcción colectiva. Comprender sus normas, su organización y su funcionamiento permite orientarse en este nuevo escenario y asumir el rol de estudiante del Nivel Superior con responsabilidad y autonomía. No se trata solo de adaptarse a una institución, sino de comenzar a forjar una trayectoria propia, sostenida en derechos, participación y compromiso.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Ley de Educación Nacional (L.E.N.) Nº 26206 establece en los artículos 34 y 35 que la Educación Superior comprende tanto a la formación desarrollada en Universidades estatales o privados autorizados, como en Institutos de Educación Superior de gestión estatal o privada.

¿Qué es el nivel superior? En nuestro país la educación superior comprende las instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, naciones, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la Ley 24.521. El artículo 3º de la mencionada norma plantea los fines y objetivos del nivel.

Art. 3º: La educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la presentación de la cultura nacional, promover la generación y el desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS IES: EL PAPEL DE LA NORMATIVA EN EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL SUPERIOR

¿Cómo se organiza la enseñanza en el Nivel Superior?

Parte de la cultura del Nivel Superior se caracteriza por su organización según normativas nacionales, provinciales e institucionales (leyes, resoluciones, decretos, circulares, notificaciones, etc.) cuyo principal propósito es tener claridad en las funciones pedagógicas y administrativas de todas y todos quienes conforman cada Instituto. Es por ello que nos parece importante presentar a modo introductorio dos grandes e importantes normativas que organizan la propuesta académica de la formación en el Nivel Superior.

¿Plan de estudios? ¿Unidades Curriculares?: El Diseño Curricular

Una de las normativas a tener en cuenta es el Diseño Curricular, el cual es un documento normativo provincial que refleja cómo desde la política educativa se espera que sea organizada la propuesta formativa de cada una de las carreras en el Nivel Superior.

En él encontraremos aspectos centrales como por ejemplo las Finalidades Formativas de la carrera, cuál es el Perfil de la egresada y egresado que se busca construir y, entre otros lineamientos, cómo se organizan las unidades curriculares (saberes a trabajar, tiempos de duración y formas de enseñanza) a través de una estructura curricular denominada Plan de Estudios.

Es importante tener siempre presente el Plan de Estudios ya que es como el mapa de ruta de cada propuesta formativa.

En él se presenta, por un lado, el listado de unidades curriculares a cursar, la carga horaria de cada una de ellas y el año en que se encuentran ubicadas (1er año, 2do y 3ero año de cada carrera). Por otro lado, el plan de estudios presenta también el régimen de correlatividades entre las distintas unidades curriculares; es decir aquellas que tienen una correlación o sucesión que puede habilitar o impedir el cursado de una unidad posterior. Conocer este régimen es fundamental a la hora de tomar decisiones tanto para cursar como para rendir exámenes finales.

El Régimen Académico Provincial.

Una vez completado el proceso de admisión, es decir haya aprobado el curso de ingreso y formalizando la inscripción definitiva y cumplimentando los requisitos solicitados; comenzará a transitar la carrera elegida como un/a estudiante de Nivel Superior. Ello implica una serie de derechos y obligaciones. En primer lugar, deberá tomar conocimiento de dos documentos importantes en el ámbito de la Educación Superior:

- El **Régimen de Correlatividades** del plan de estudios de la carrera y,

- El **Régimen Académico Provincial (RAP**) (Res 6815-E-11), que contiene la reglamentación general para el cursado y aprobación de los espacios/ las unidades curriculares, es decir lo que comúnmente se conocen como materias. En el RAP encontrarán las normas generales que organizan el 10 funcionamiento académico y administrativo en todos los Institutos de Educación Superior de nuestra provincia

En lo que al **Régimen de Correlatividades** se refiere, debe saber que, en este nivel, lo tendrá que tener presente para progresar en el cursado de la carrera. De acuerdo al mismo, ya sea al momento de inscripción para cursar o rendir un/a espacio/unidad curricular, el requisito será haber **aprobado o regularizado "la correlativa"**, es decir aquella materia que, por sus contenidos, debe aprenderse con anterioridad y de ese modo servir como base para apropiar saberes nuevos.

Un buen consejo es **planificar la trayectoria estudiantil** priorizando el circuito de correlatividades especialmente cuando decida cuál examen preparar en primer lugar.

Cada vez que inicie un año académico o cuatrimestre (primero o segundo) deberá inscribirse en la materia que desee cursar, en Departamento Alumnos, a través del **Sistema de Autogestión**.

Una aclaración: al iniciar el primer año de la carrera queda automáticamente inscripto en todas las materias de primer año anuales y del primer cuatrimestre.

CONDICIONES PARA ACREDITAR LAS MATERIAS

CONDICIÓN	**Régimen académico provincial Res. 6815-E/11**
PROMOCIÓN	80% Asistencia 80% Trabajos Prácticos aprobados 100% de evaluaciones aprobadas con calificación 7 (siete) como mínimo con una instancia recuperatoria por cada evaluación. Coloquio aprobado con calificación 7 (siete).
REGULAR Esta condición tiene una duración de 2 (dos) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando el estudiante resultare desaprobado por tercera vez en la instancia de examen final.	65% Asistencia 80% Trabajos Prácticos aprobados 100% de evaluaciones aprobadas con calificación 4 (cuatro) como mínimo con una instancia recuperatoria por cada evaluación. Como alumno regular deberá rendir examen final ante tribunal en los turnos reglamentarios.
LIBRE En esta condición deberá rendir ante tribunal examinador, incluyendo una instancia escrita y oral (ambas eliminatorias). Deberá aprobar cualquiera de las instancias con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Si el alumno fuera aplazado por tercera vez, deberá cursar o recursar.	Por opción: solo si lo admite el diseño curricular de la carrera. Por condición: b.1. Por no obtener la regularidad b.2. Por pérdida de la regularidad

¿QUÉ ES UN EXAMEN FINAL?

Es una instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean en una MATERIA para los alumnos en condición Regular o Libre.

EL EXAMEN FINAL

Durante la enseñanza remota de emergencia el examen final de acreditación se regirá con idéntico protocolo aprobado por la Institución y toda otra norma que con posterioridad emita el Ministerio de Educación.

¿CUÁNDO SE RINDE?

Los exámenes finales se desarrollan en un **"turno"** y las veces que el tribunal examinador conformado por tres profesores (presidente, 1º vocal, 2º vocal) es convocado en el mismo turno se denomina **"llamado".**

¿CUÁNTOS ESPACIOS/UNIDADES CURRICULARES PUEDO RENDIR EN UNA MISMA FECHA?

Hasta 2 (dos) siempre que no sean correlativas entre sí.

¿QUÉ ELEMENTOS NO DEBO OLVIDAR TRAER A UN EXAMEN FINAL?

- DNI
- Libreta Estudiantil.
- Programa del/la Espacio/Unidad Curricular.
- Puntualidad tanto en la presencialidad como en la virtualidad.

¿QUÉ SUCEDE SI ME AUSENTO A UN EXAMEN FINAL?

Si por razones de **salud o duelo** no puede presentarse a rendir debe informarle al coordinador de carrera el mismo día del examen, salvo caso excepcional, y justificar presentando las certificaciones correspondientes dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles.

UNA ACLARACIÓN IMPORTANTE CON RESPECTO A LAS COMISIONES

Iniciar el cursado de una carrera, requiere aprender un oficio: el oficio de estudiar, como también requiere de la entrega y el deseo de conocer y aprender sobre lo que se eligió y los enigmas que se le plantean a cada uno respecto de eso por conocer. En el caso del estudiante adulto, es, probablemente tomarse el tiempo de llevar a cabo algo que tal vez en otro momento no se pudo concretar. El camino por recorrer no está libre de obstáculos y constituye un verdadero desafío superarlos.

Los tipos de Turnos existentes son:

<table>
<tr><th colspan="3">ORDINARIO</th><th>EXTRAORDINARIO</th></tr>
<tr><td>Febrero/Marzo</td><td>Dos llamados</td><td>Con suspensión de clases</td><td rowspan="5">Autorizado por la Rectora mediante resolución en los siguientes casos:
Cuando hayas terminado de cursar y regularizar todas las U.C. de la carrera.
Cuando tengas pendientes 2 (dos) U.C. para completar estudios.</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Un llamado</td><td>Sin suspensión de clases</td></tr>
<tr><td>Julio/Agosto</td><td>Un llamado</td><td>Con suspensión de clases</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>Un llamado</td><td>Sin suspensión de clases</td></tr>
<tr><td>Noviembre/Diciembre</td><td>Dos llamados</td><td>Con suspensión de clases</td></tr>
<tr><td colspan="4">Asimismo, la Dirección de Educación Superior puede determinar turnos en carácter excepcional.</td></tr>
</table>

RAP IES 11

El Régimen Académico Provincial (RAP) es el marco normativo que regula la formación de los estudiantes en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia de Jujuy.

Es fundamental que los ingresantes conozcan en profundidad los aspectos principales del RAP, ya que este regula tanto el ingreso como la trayectoria formativa, la permanencia y la promoción dentro de las carreras. Entender las reglas y requisitos que establece el RAP no solo promueve un tránsito académico más seguro y eficiente, sino que también fomenta la autonomía, la responsabilidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes en el marco de la educación superior.

Para facilitar tu acceso a esta información esencial, hemos preparado un link de acceso directo que te permitirá descargar y consultar el archivo completo del RAP. Allí encontrarás todo lo necesario para orientarte y aprovechar al máximo tu experiencia académica.

¡Ingresa al siguiente LINK!

https://drive.google.com/file/d/1C5DbE5OvZ6q2mVnPNMyMtca1XKPuFsFe/view?usp=sharing

EJE II:

SER TÉCNICO EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

No todo camino es elegido al azar. Don Quijote se nombra caballero andante porque siente que esa es su misión. De manera similar, elegir la carrera de Acompañamiento Terapéutico es asumir una vocación de cuidado, presencia y acompañamiento allí donde otros atraviesan el sufrimiento.

Este eje presenta las características de la carrera, su plan de estudios y el perfil del egresado, como quien despliega un mapa antes de emprender la travesía. Aquí comienza a delinearse la identidad del Acompañante Terapéutico: un agente de salud que interviene en la vida cotidiana, en articulación con equipos interdisciplinarios, sosteniendo una práctica ética, situada y respetuosa de la singularidad de cada sujeto.

CARRERA:

TECNICATURA SUPERIOR EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

TÍTULO:

TÉCNICO SUPERIOR EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

FAMILIA PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE:

SALUD

DURACIÓN DE LA CARRERA:

3 AÑOS

MODALIDAD:

PRESENCIAL

OBJETIVO: DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

QUE EL ESTUDIANTE:

1. Desarrolle competencias para insertarse en un equipo interdisciplinario, que le permita trabajar en:
    - Tratamiento, rehabilitación y reinserción social y laboral en lo que respecta a asistencia, prevención y promoción de la salud mental
    - Abordar las distintas patologías mentales que ponen a las personas en situación de discapacidad (transitoria o permanente) o en situación de vulnerabilidad social en las diferentes fases del ciclo vital (vínculo neonatal, niñez, adolescentes, adultos, adultos mayores).
    - Instrumentar elementos que permitan el acompañamiento a personas con discapacidad física (transitoria o permanente); enfermedades orgánicas crónicas y/o terminales.
2. Implemente los instrumentos teóricos-técnicos necesarios para realizar su práctica, atendiendo las demandas del contexto socio-cultural.

3. Alcance una formación-profesional idónea dentro de las áreas de competencia del Acompañamiento Terapéutico en los ámbitos clínicos, educativos, jurídicos, sanitario.
4. Desarrolle habilidades para: Acompañar a la persona con padecimiento mental en lo que respecta a la internación, externación y/o reinserción social.
5. Desarrolle actitudes y aptitudes que le permitan constituirse en agente promotor de salud en equipos interdisciplinarios, en cualquiera de las áreas en que ejerza su actividad siendo auxiliar de un tratamiento dirigido y supervisado por otros profesionales (médico, psiquiatra, psicólogo, trabajador social).

ALCANCE DEL TÍTULO:

Al ser un título que designa una competencia de acción derivada o compartida, el Técnico en Acompañamiento Terapéutico es un profesional habilitado para:

- Colaborar en tareas de sostén y acompañamiento a personas que por alguna circunstancia (padecimiento mental o discapacidad, transitoria o permanente) no puedan desenvolverse por sí misma.
- Colaborar en investigaciones en el campo de la Salud Mental. Participar y colaborar en la elaboración de planificaciones de programas de salud y acción social.
- Colaborar en equipos interdisciplinarios en el campo de la Salud Mental.
- Acompañar y propiciar el desempeño favorable de los pacientes en los procesos de integración e inclusión, en las distintas actividades cotidianas, en la red comunitaria e instituciones donde éstas se desarrollen.
- Favorecer la socialización y reinserción social y/o laboral de la persona mediante estrategias que permitan potenciar sus recursos saludables.
- Asesorar y trabajar en forma mancomunada con los familiares del acompañado a fin de promover su inserción familiar.
- Realizar informes del proceso terapéutico al equipo tratante que den cuenta del desenvolvimiento del acompañado en los distintos ámbitos en que participa.
- Recibir asesoramiento y supervisión profesional permanente sobre las estrategias implementadas en el acompañamiento del paciente.

CAMPO OCUPACIONAL:

Podrá desempeñarse en los siguientes lugares:

- Servicios de atención para pacientes con trastornos psiquiátricos o por uso de sustancias psicoactivas (públicos y privados).
- Hospitales polivalentes
- Hospital de día
- Centro de día Centro educativo terapéutico
- Comunidad terapéutica
- Casa de medio camino (residencias)
- Talleres laborales protegidos
- Centro de rehabilitación psicofísica
- En el ámbito ambulatorio:
- Internación domiciliaria
- Abordaje en la vida diaria del paciente
- Instituciones escolares públicas o privadas
- Nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario
- Escuelas especiales
- Geriátricos
- Justicia (visitas controladas, re-vinculación paterno filial)
- Otros

PERFIL DEL EGRESADO:

El Técnico en Acompañamiento Terapéutico deberá ser capaz de: Comprender la complejidad del campo del Acompañamiento Terapéutico a partir de su formación teórico-práctica. Establecer con los pacientes un vínculo reparador constructivo, que le permita a los mismos la realización de sus máximas posibilidades y potencialidades. Para ello el Acompañante Terapéutico se insertará en la vida cotidiana del acompañado para su

cuidado, atención y seguimiento. Entender las conductas de su acompañado conforme a su cuadro psicopatológico, sus necesidades y sus particularidades evolutivas. Adquirir conocimientos teóricos, técnicos y éticos que le permitan desarrollar su rol desde un abordaje sensible y comprometido con la problemática abordada. Comprender e insertarse en el funcionamiento de las instituciones en las que asista al acompañado, desarrollando habilidades cognitivas y sociales necesarias para el trabajo en equipo interdisciplinario.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen de Cursada			Total horas cátedra
			Anual	1° C	2° C	
1º	1	Introducción al Acompañamiento Terapéutico	4			128
	2	Primeros Auxilios			3	48
	3	Bases Biológicas del Comportamiento Humano	4			128
	4	Psicología General	3			96
	5	Psicología del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia	4			128
	6	Psicología Social y Comunitaria	3			96
	7	Políticas Públicas y Legislación en Salud		3		48
	8	EDI	3			96
	9	Práctica Profesionalizante I	6			192
	Total Horas Primer Año		**27**	**3**	**3**	**960**
2°	10	Neurofisiopatología	3			96
	11	Metodología de la Investigación			3	48
	12	Teorías y Estrategias de Abordaje en el Acompañamiento Terapéutico	3			96
	13	Psicología del Desarrollo del Adulto y Adulto Mayor	3			96
	14	Psicopatología I	5			160
	15	Estrategias de Abordaje Familiar		3		48
	16	Psicomotricidad Aplicada al Acompañamiento Terapéutico			4	64
	17	Análisis de las Organizaciones e Instituciones	3			96
	18	Dinámica de Grupo		3		48
	19	Práctica Profesionalizante II	6			192
Total Horas Segundo Año			**23**	**6**	**7**	**944**

3º	20	Bioética y Deontología			3	48
	21	Principios de Farmacología		3		48
	22	Psicopatología II	5			160
	23	TIC en el Acompañamiento Terapéutico		3		48
	24	Discapacidad e Inclusión	3			96
	25	Técnicas de Abordaje de Acompañamiento Terapéutico	3			96
	26	Taller de Redacción de Informes		3		48
	27	Taller de Casos Clínicos			3	48
	28	Abordajes de Urgencias en Salud Mental			3	48
	29	Práctica Profesionalizante III	8			256
	30	EDI	3			96
	Total Horas Tercer Año		**22**	**9**	**9**	**992**
Total Horas Cátedra de la Carrera						**2896**
Total Horas Reloj de la Carrera						**1930**

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS CURRICULARES POR CAMPOS DE FORMACIÓN

Campo de Formación	Orden	Espacios Curriculares	Horas Cátedras	%
General	2	Primeros Auxilios	48	8,28
	7	Políticas Públicas y Legislación en Salud	48	
	8	EDI	96	
	11	Metodología de la Investigación	48	
Total por Campo de Formación			**240**	
De Fundamento	3	Bases Biológicas del Comportamiento Humano	128	19,33
	4	Psicología General	96	
	10	Neurofisiopatología	96	
	17	Análisis de las Organizaciones e Instituciones	96	
	20	Bioética y Deontología	48	
	21	Principios de Farmacología	48	

	28	Abordaje en Urgencias de Salud Mental	48	
Total por Campo de Formación			**560**	
Especifica	1	Introducción al Acompañamiento Terapéutico	128	**50,27**
	5	Psicología del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia	128	
	6	Psicología Social y Comunitaria	96	
	12	Teorías y Estrategias de Abordaje en el Acompañamiento Terapéutico	96	
	13	Psicología del Desarrollo del Adulto y Adulto Mayor	96	
	14	Psicopatología I	160	
	15	Estrategias de Abordaje Familiar	48	
	16	Psicomotricidad Aplicada al Acompañamiento Terapéutico	64	
	18	Dinámica de Grupo	48	
	22	Psicopatología II	160	
	23	TICs en el Acompañamiento Terapéutico	48	
	24	Discapacidad e Inclusión	96	
	25	Técnicas de Abordaje de Acompañamiento Terapéutico	96	
	26	Taller de Redacción de Informes	48	
	27	Taller de Casos Clínicos	48	
	30	EDI	96	
Total por Campo de Formación			**1456**	
Practica Profesionalizante	9	Práctica Profesionalizante I	192	**22,10**
	19	Práctica Profesionalizante II	192	
	30	Práctica Profesionalizante III	256	

PLAN DE CORRELATIVIDADES Y RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen	Correlatividades		Régimen de aprobación
				Regularizadas para cursar	Aprobadas para rendir	
1º	1	Introducción al Acompañamiento terapéutico	Anual	---	---	Examen Final
	2	Primeros Auxilios	2°C	---	---	Promocional Examen Final
	3	Bases Biológicas del Comportamiento Humano	Anual	---	---	Examen Final
	4	Psicología General	Anual	---	---	Examen Final
	5	Psicología del Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia	Anual	---	---	Examen Final
	6	Psicología Social y Comunitaria	Anual	---	---	Examen Final
	7	Políticas Públicas y Legislación en Salud	1°C	---	---	Promocional Examen final
	8	EDI	Anual	-----	-----	Promocional Examen Final
	9	Práctica Profesionalizante I	Anual	---	---	Promocional
2º	10	Neurofisiopatología	Anual	3	3	Examen Final
	11	Metodología de la Investigación	2° C	1	1	Promocional Examen Final
	12	Teorías y Estrategias de Abordaje en el Acompañamiento Terapéutico	Anual	1,4.	1,4,5	Examen Final
	13	Psicología del Desarrollo del Adulto y el Adulto Mayor	Anual	1,4,5.	1,4,5.	Examen Final
	14	Psicopatologíal	Anual	1,4.	1,4.	Examen Final
	15	Estrategias de Abordaje Familiar	1°C	4,5.	4,5.	Examen Final
	16	Psicomotricidad aplicada al Acompañamiento Terapéutico.	2°C	2,3.	2,3.	Promocional Examen Final
	17	Análisis de las Organizaciones e Instituciones.	Anual	6,7	6,7	Promocional Examen Final
	18	Dinámica de Grupo	1°C	4,6.	4,6.	Promocional Examen Final
	19	Práctica Profesionalizante II	Anual	1,2,4,7,9.	1,2,4,7,9.	Promocional
3º	20	Bioética y Deontología	2°C	7,17	7,17	Promocional Examen Final

	21	Principios de Farmacología	1º C	1, 2, 3, 10.	1,2, 3,10.	Examen Final
	22	Psicopatología II	Anual	1,4,10,14.	1,4,10,14.	Examen Final
	23	TIC en el Acompañamiento Terapéutico	1°C	1,12.	1,12.	Promocional Examen Final
	24	Discapacidad e inclusión	Anual	4, 5,12, 13, 15.	4,5,12,13 15.	Examen Final
	25	Técnicas de Abordaje de Acompañamiento Terapéutico	Anual	1,4,9,12	1,4,9,12.	Examen Final
	26	Taller de Redacción de Informes	1°C	1,11.	1,11.	Promocional Examen Final
	27	Taller de Casos Clínicos	2°C	12,14.	12,14.	Promocional Examen final
	28	Abordajes de Urgencias en Salud Mental	2°C	2,3,14.	2,3,14.	Examen final
	29	Practica Profesionalizante III	Anual	5,12,14,15, 16,17,18	5,12,14, 15,19.	Promocional
	30	EDI	Anual	---	---	Examen final.

EJE N° III:

TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Todo viajero necesita herramientas. Don Quijote afila su lanza, ajusta su armadura y ensilla a Rocinante antes de salir al mundo. El estudiante del Nivel Superior también requiere recursos que le permitan sostener el camino del aprendizaje con constancia y sentido.

Este eje propone técnicas de estudio que funcionan como aliados en la travesía académica: estrategias para organizar el tiempo, comprender los textos, elaborar la información y consolidar los conocimientos en la memoria. Aprender a estudiar no es un detalle menor, sino una condición fundamental para avanzar con mayor seguridad, transformar el esfuerzo en saber y preparar el terreno para la futura práctica profesional.

Estudiar en el nivel superior representa un desafío que va más allá de la adquisición de conocimientos técnicos. Es también una oportunidad para desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, técnicas de estudio y estrategias de organización personal que acompañarán a los estudiantes a lo largo de su carrera y vida profesional.

La Cartilla de Técnicas de Estudio está diseñada para proporcionar herramientas prácticas y orientaciones claras que faciliten este proceso. En ella encontrarás métodos efectivos para administrar el tiempo, mejorar la comprensión lectora, tomar apuntes, realizar resúmenes y abordar exámenes con mayor preparación.

Conocer y aplicar estas estrategias no solo mejorará tu desempeño académico, sino que también fomentará un aprendizaje más significativo y autónomo.

Este recurso será una guía esencial para aprovechar al máximo tu experiencia en la educación superior.

Para facilitar tu acceso a esta información esencial, hemos preparado un link de acceso directo que te permitirá descargar y consultar el archivo completo del

¡Ingresa al siguiente LINK!
https://drive.google.com/file/d/1PQkaGxBXE8Q7EKESvWEqCqlb9vFuPDoa/view?usp=sharing

EJE IV:

TEORIAS ENFOQUES EN AT

Don Quijote mira el mundo a través de sus lecturas; ellas orientan su modo de interpretar la realidad y de intervenir en ella. De manera análoga, el Acompañante Terapéutico necesita marcos teóricos que le permitan comprender la conducta humana, los vínculos y el padecimiento psíquico desde una mirada amplia e integrada.

Este eje ofrece una base conceptual indispensable, recorriendo distintas teorías, modelos y enfoques de la psicología que nutren el campo del AT. No se trata de acumular saberes, sino de comenzar a construir una forma de pensar la intervención, fortaleciendo una práctica reflexiva, ética y profesional, que reconozca la complejidad de cada situación y de cada sujeto.

¿ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO Y POR QUÉ ES TERAPÉUTICO?

La práctica del AT deja de ser solo un acompañamiento (sin menospreciar el hecho de acompañar, acción también muy importante y valiosa) para transformarse en terapéutico, en la medida que existe una teoría o conjunto de referencias que orientan y respaldan las estrategias e intervenciones que realiza un AT. En este dispositivo el adjetivo “terapéutico” determina nuestra praxis más allá del acompañar y tiene que ver con un cierto ordenamiento, con un marco teórico que da direccionalidad a la práctica volviéndola clínica. La clínica entonces se hace a partir de un sistema de referencias que ordena y analiza los datos para brindar un tratamiento. La clínica del AT puede ser definida como “una clínica entre varios”, que se sostiene en equipo, teniendo como ordenador posible distintas corrientes psicológicas (como el marco psicoanalítico) (Pérez, 2016).

El sujeto como eje del acompañamiento terapéutico

¿Porque es importante comprender la subjetividad y el psiquismo para el Acompañante Terapéutico? Subjetividad y psiquismo como pilares del acompañamiento

El acompañamiento terapéutico no es una tarea meramente técnica o asistencial, sino una intervención que considera al sujeto como un ser complejo, moldeado tanto por sus procesos internos (el psiquismo) como por las condiciones históricas, sociales y culturales que lo atraviesan. Según Silvia Bleichmar (2007), comprender al sujeto implica abordar su sufrimiento desde una perspectiva que articule tanto lo singular como las condiciones estructurales que lo determinan: "El sujeto no es solo producto de su historia individual, sino también del entramado social y cultural en el que está inmerso".

En el campo del acompañamiento terapéutico AT, comprender los conceptos de subjetividad y psiquismo resulta esencial para realizar intervenciones éticas y efectivas. Estos conceptos permiten al AT interpretar las formas en que las personas construyen su identidad, procesan sus experiencias y enfrentan el sufrimiento psíquico. Como plantea Berger y Luckmann (1997), "la realidad se construye socialmente", y esta construcción define tanto las formas de subjetivación como las interacciones con el entorno.

Subjetividad: La construcción social e histórica del sujeto.

La subjetividad se define como el proceso mediante el cual las personas construyen su identidad y sentido de sí mismas en función de sus experiencias en contextos sociales e históricos específicos (De Lauretis, 1987). Este concepto implica reconocer que los sujetos no son entidades aisladas, sino que están configurados por su entorno cultural, político y económico.

Poder identificar las condiciones socio históricas que moldean la subjetividad de las personas permite al AT comprender cómo estas influyen en sus formas de pensar, sentir y actuar. Silvia Bleichmar (2005) resalta que la subjetividad está estrechamente ligada al contexto social, ya que "las configuraciones subjetivas son inseparables de las condiciones materiales y simbólicas de existencia".

El **psiquismo** engloba los procesos internos del sujeto, tanto conscientes como inconscientes, incluyendo deseos, pensamientos, emociones y conflictos. Freud (1920) definió el psiquismo como un sistema dinámico donde las pulsiones y los mecanismos de defensa interactúan constantemente para gestionar el malestar.

Silvia Bleichmar (2007) amplía esta perspectiva al señalar que el psiquismo no puede comprenderse de manera aislada, ya que las dinámicas internas del sujeto están profundamente influenciadas por los vínculos que establece con los otros y con su entorno.

Comprender el psiquismo permite al AT interpretar las conductas y malestares más allá de los síntomas observables. Esto incluye atender los procesos inconscientes que subyacen a los comportamientos y explorar cómo los conflictos internos del sujeto se relacionan con sus vivencias externas.

El AT trabaja con sujetos cuyas subjetividades y psiquismos están frecuentemente en tensión debido a diversas circunstancias: padecimientos mentales, consumos problemáticos, violencia, exclusión social, entre otros. Estas condiciones pueden fragmentar la identidad del sujeto y afectar su capacidad de establecer vínculos saludables.

El objetivo principal del acompañamiento terapéutico es sostener procesos de re-subjetivación, es decir, facilitar que el sujeto pueda resignificar su experiencia, reconstruir su identidad y establecer relaciones significativas con su entorno. Como señala Silvia Bleichmar (2005), el sufrimiento subjetivo debe abordarse desde una comprensión integral que contemple tanto las determinaciones individuales como las estructurales.

El AT logra esto mediante:

- La escucha activa y empática: Validando las experiencias del sujeto sin reducirlas a etiquetas diagnósticas.
- La construcción de un vínculo terapéutico: Basado en el respeto, la confianza y la sensibilidad hacia la singularidad del otro.
- La intervención situada: Considerando tanto los aspectos internos del psiquismo como las condiciones externas que afectan la subjetividad del sujeto.

Podemos decir que el conocimiento profundo de la subjetividad y el psiquismo brinda al AT herramientas teóricas y prácticas esenciales para abordar la complejidad de las situaciones que enfrenta en su labor. Reconocer que cada sujeto es único y está atravesado por múltiples dimensiones –histórica, social, cultural, afectiva y psíquica– es clave para intervenir de manera ética y efectiva.

Como plantea Bleichmar (2007), el acompañamiento no solo implica la presencia del AT en la vida cotidiana del sujeto, sino también su capacidad de facilitar procesos de transformación personal y social. Este desafío requiere una formación sólida que articule teoría y práctica, y que priorice siempre la ética, la empatía y el respeto por la singularidad del sujeto. La autora destaca que la subjetividad contemporánea está marcada por avances tecnológicos y cambios en los vínculos sociales y familiares. Por ejemplo, el deseo de tener hijos ya no se relaciona únicamente con la procreación instintiva, sino con la trascendencia y la transmisión del amor. Estos cambios plantean nuevos desafíos para el psicoanálisis, que debe adaptarse a las transformaciones sociales sin abandonar conceptos clave como la represión y el deseo.

En síntesis, Bleichmar propone un marco teórico que diferencia entre:

1. Producción de subjetividad: el resultado de las configuraciones sociales y políticas.

2. Constitución del psiquismo: procesos internos que exceden lo histórico y lo social, pero que se articulan con ellos.

Ambos niveles son esenciales para comprender cómo se configura el sujeto en contextos históricos y sociales cambiantes.

EL Acompañamiento Terapéutico se funda en establecer un vínculo con el otro, creando un lazo sólido, en una apuesta al compromiso, a lo estable, en tiempos de predominio de lo efímero, de consumismo.

El vínculo que se establece con nuestros pacientes es el medio por el cual posibilitar los cambios que les permitan establecer otras relaciones. Es allí donde la posición ética consiste en consolidar una relación estable, segura, contenedora, que favorezca el fortalecimiento en contraposición a la fragilidad a la que nos subsume la cultura de lo efímero Por otro lado, vemos una creciente segregación de personas, grupos y comunidades que son consideradas diferentes de los ideales dominantes. Momentos en los que los valores proclamados son la productividad, la belleza, la juventud, la salud, la propiedad, produciendo de distintas formas, la exclusión, la marginación de quienes no reúnen estos atributos, sujetos que por distintas causas o circunstancias no se adecuan a este modelo.

Una sociedad que iguala, que produce en serie y propone soluciones estandarizadas, en un modelo que no contempla la singularidad.

Silvia Bleichmar dice que en nuestras sociedades se produce una desarticulación de la empatía con los otros: la ausencia del reconocimiento de lo que le pasa al otro. Peor que marginar es ignorar, es el no reconocimiento de la existencia de alguien en su dolor, en su individualidad. Sensación de aniquilamiento en la posibilidad de ser un sujeto para alguien.

Para Emmanuel Levinas la ética no es tanto un conjunto de normas, sino fundamentalmente atención a lo humano. El reconocimiento del otro humano que no puede dejarnos indiferente es el lugar en el que se implanta una ética del acompañamiento terapéutico. Es a partir de esa mirada de reconocimiento, desde donde debe erigirse la práctica del AT; desde la empatía, en complicidad con aquellos lugares aún deseantes que da lugar al tejido de una red que fundamentalmente tenga la posibilidad de reconocer al otro como un sujeto singular, reconociendo su dolor, escuchando lo que tiene para decirnos. Desde allí es donde el sujeto es mirado y escuchado, por el equipo terapéutico, por un profesional que determinará la inclusión de un AT. Esta inclusión permite diseñar una estrategia acorde a la situación de cada sujeto en tratamiento y a sus circunstancias singulares. No obra desde un lugar de unificación, de propuestas terapéuticas estandarizadas que igualan a los pacientes bajo un mismo diagnóstico y un mismo dispositivo. Esta posibilidad que brinda el acompañamiento de crear ese nuevo ritmo, ese nuevo espacio “entre” ambos, es desde nuestra perspectiva, el fundamento de una ética del acompañar.

Más allá de los cambios históricos y de los valores dominantes en una u otra época, la presencia del otro se plantea como premisa de humanización. En esta presencia insoslayable del semejante se encuentra el fundamento de la ética, que sostiene también al ejercicio del A.T.

Entonces, a partir de que la vida del ser humano depende en parte de la presencia del otro, no tan solo material sino subjetivamente, esto se convierte en el fundamento de la ética como reconocimiento de nuestra obligación hacia el semejante.

El vínculo que establece el acompañante con el sujeto, es de fundamental importancia, es su principal herramienta. Debe instaurarse fuera del egoísmo, debe posicionarse en un lugar que le permita crecer, cambiar, que respete la subjetividad, que no la obture. La mirada del acompañante debe ser una mirada sin prejuicios que demarque posibilidades y no restricciones.

Al decir "fuera del egoísmo" no proponemos el retorno a una postura de beneficencia o caridad, tan alienantes como la reclusión psiquiátrica. Nos referimos a la capacidad del AT de suspender su propia subjetividad (sus ideales, sus anhelos, sus valores) para alojar la emergencia de la subjetividad de ese otro -semejante pero diferente- reconocerla y propiciar algo que contribuya a su realización.

El posicionamiento del AT. debería ser abierto a la irrupción, a la aparición de aquello del denominado paciente que es, al mismo tiempo expresión de su subjetividad y de lo segregado por la sociedad

Entonces podemos pensar, la práctica del Acompañamiento Terapéutico se caracteriza por su versatilidad teórica y su capacidad de adaptarse a diversas necesidades y contextos. Tal como se señaló anteriormente, aunque el psicoanálisis constituye el enfoque predominante en el desarrollo teórico del AT, su articulación con otros enfoques permite construir una intervención integral y situada. Esto lo convierte en un dispositivo flexible que se enriquece al integrarse en equipos interdisciplinarios y responder a estrategias terapéuticas diversas.

Desde el **psicoanálisis**, la labor del AT se fundamenta en la comprensión de la constitución subjetiva del psiquismo, el vínculo y la ética. Según Sigmund Freud y los desarrollos posteriores de Donald Winnicott y Jacques Lacan, el vínculo terapéutico se convierte en un espacio potencial para que el sujeto reconstruya aspectos de su subjetividad y se posicione frente a sus padecimientos. En este sentido, el AT no solo acompaña, sino que también facilita procesos de simbolización y resignificación.

Por su parte, la **Psicología Social**, en particular desde los aportes de Enrique Pichon Rivière, amplía la mirada hacia los contextos sociales y comunitarios en los que se desarrolla la intervención del AT. Conceptos como el **vínculo social**, la **grupalidad** y las **prácticas en la vida cotidiana** permiten al AT comprender la trama sociohistórica que atraviesa al sujeto y diseñar intervenciones que promuevan su inclusión y participación activa en la comunidad.

El **Modelo Médico-Psiquiátrico**, aunque históricamente centrado en el diagnóstico y el tratamiento biomédico, aporta herramientas esenciales para el manejo de síntomas, la adherencia al tratamiento y la comprensión de las patologías desde un enfoque clínico. La integración de este modelo permite al AT articular su práctica con el equipo tratante y responder a las demandas específicas del tratamiento, manteniendo siempre una perspectiva ética y respetuosa de la subjetividad del acompañado.

Asimismo, los enfoques **cognitivo-conductuales** pueden complementar la labor del AT al proporcionar estrategias prácticas y estructuradas para intervenir en los comportamientos disfuncionales y promover habilidades adaptativas. Esto resulta especialmente útil en contextos donde el acompañamiento requiere la implementación de planes concretos para el desarrollo de autonomía y bienestar.

Finalmente, la **Psicología Humanista**, desde autores como Carl Rogers y Viktor Frankl, aporta una mirada centrada en la persona, valorando su experiencia subjetiva y su capacidad de autodeterminación. Este enfoque resalta la importancia del vínculo empático entre el AT y el acompañado, y promueve el desarrollo de la autenticidad, la resiliencia y el sentido de vida.

La pluralidad de teorías y enfoques que, lejos de contradecirse, pueden integrarse de manera complementaria según las características del caso y el equipo tratante. Este abanico de perspectivas teóricas permite que el AT no solo acompañe al sujeto en su padecimiento, sino que también favorezca su autonomía, su inserción en la vida cotidiana y su transformación personal y social.

Referencias Bibliográficas

- Berger, P. & Luckmann, T. (1997). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu.
- Bleichmar, S. (2005). *Avatares del sujeto y del vínculo: Temas de clínica psicoanalítica*. Paidós.
- Bleichmar, S. (2007). *Clínica del sufrimiento psíquico*. Paidós.
- De Lauretis, T. (1987). *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. Indiana University Press.
- Freud, S. (1920). *Más allá del principio de placer*. Amorrortu
- Banszczyk, B. (2017). “Representación social del rol del acompañante terapéutico que poseen profesionales de salud mental, que trabajan con acompañantes terapéuticos”. Trabajo Final de Graduación. Licenciatura en Psicología. Universidad

Empresarial S. 21. Recuperado en: https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/13768/BANSZCZYK%20B RIAN.pdf?sequence=

- Chaui Berlinck, L. (2017). “AT en lo cotidiano, una clínica en las fronteras”. En: Acompañamiento Terapéutico: Clínica en las Fronteras. (pp. 13-20) Compiladoras: María Laura Frank, Maricel Costa, Dolores Hernández. Córdoba, (1° Edición ed.). Brujas.

- Rossi, G. (2007). “Acompañamiento Terapéutico: lo cotidiano, las redes, y sus interlocutores”, Buenos Aires, Edit, Polemos. Recuperado en: http://cordescorporacion.cl/wp-content/uploads/2020/07/Acompa%C3%B1amientoTerapeutico-.pdf

- Rossi, G. (2014). “El AT y su lazo social: interpelaciones a la comunidad, lugares para el malestar singular”. Recuperado en: https://www.actoterapeutico.com.ar/wpcontent/uploads/2019/01/2014-ROSSI-G-en-REVISTA-ATRAVESSAR-PresentacCongreso-AT-DF-MEXICO-Publicadonro-4-2014.pdf

- Rossi, G. (2017). “Formación y Formalización en el Acompañamiento Terapéutico. Situación en Latinoamérica”.

EJE V:

HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

Ningún camino se inicia sin huellas previas. Este eje propone detenerse a mirar hacia atrás para comprender cómo y por qué surge el Acompañamiento Terapéutico, cuáles fueron las luchas que lo hicieron posible y qué sentidos se juegan hoy en su ejercicio profesional.
Así como Don Quijote se inscribe en una tradición de caballería, el AT se inscribe en los movimientos de reforma psiquiátrica, en la crítica al manicomio y en el paradigma de la salud mental comunitaria y de derechos. Conocer su historia, su desarrollo en la Argentina y su marco legal en la provincia de Jujuy permite comprender la identidad del AT como una práctica clínica y política, en permanente construcción.

INTRODUCCIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

El Acompañamiento Terapéutico se construye como una práctica clínica situada, comprometida con el padecimiento subjetivo, con la dignidad de las personas y con la defensa de sus derechos. No surge como una técnica neutral, sino como una respuesta histórica, ética y política frente a modos de asistencia que han producido exclusión, segregación y silenciamiento.

HISTORIA DEL SURGIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

Situar al Acompañamiento Terapéutico dentro de la clínica contemporánea y del complejo entramado del campo de la salud mental exige realizar una revisión histórica que permita comprender sus condiciones de surgimiento, su desarrollo y los desafíos actuales que atraviesan esta práctica.

La historización del AT no constituye un mero ejercicio académico. Así como en la clínica resulta fundamental considerar la historia y la singularidad del sujeto acompañado, comprender la historia del dispositivo es un requisito ineludible para otorgar sentido y coherencia a la práctica profesional.

Pensar el surgimiento del AT implica no disociarlo de su contexto social, cultural, histórico e ideológico. En este sentido, su aparición se encuentra estrechamente ligada a los movimientos de crítica y transformación del modelo manicomial, y a la búsqueda de nuevas modalidades de abordaje del padecimiento mental que superaran la lógica del encierro y del control social.

LA LÓGICA MANICOMIAL

Para comprender el lugar que ocupa el Acompañamiento Terapéutico en el campo de la salud mental, resulta imprescindible detenernos en el análisis de la lógica manicomial. El manicomio no puede ser pensado únicamente como una institución de atención sanitaria, sino como un dispositivo histórico de control social y producción de subjetividad.

La lógica manicomial se sostiene en una base ideológica precisa: define la diferencia como anormalidad, etiqueta al sujeto como “loco” y legitima prácticas de segregación, aislamiento y disciplinamiento. Bajo el modelo médico hegemónico, la asistencia se organiza desde relaciones de poder verticales, donde el saber psiquiátrico ocupa un lugar central y excluyente, en detrimento de abordajes interdisciplinarios y comunitarios.

Lejos de ofrecer un tratamiento integral, la institución manicomial tiende a producir un padecimiento adicional al ya existente. La persona internada experimenta la ruptura de sus lazos sociales, familiares y comunitarios, la pérdida progresiva de su identidad, la suspensión de derechos civiles, humanos y políticos, y la naturalización del encierro como destino.

Estas prácticas reiteradas de privación suelen adquirir un estatuto de normalidad institucional, generando una pérdida de sensibilidad, de pensamiento crítico y de capacidad creativa, tanto en quienes habitan la institución como en quienes trabajan en ella. El manicomio, en lugar de cumplir una función terapéutica, profundiza el desamparo y la exclusión social.

DEL MODELO MANICOMIAL AL MODELO DE SALUD MENTAL

A partir de las décadas de 1960 y 1970, comienzan a gestarse a nivel internacional y regional fuertes movimientos de crítica al modelo psiquiátrico tradicional. Estas transformaciones dan lugar a un cambio de paradigma: el pasaje del modelo manicomial hacia un modelo de salud mental.

Este movimiento no fue homogéneo ni lineal, sino el resultado del entrecruzamiento de múltiples corrientes teóricas y experiencias institucionales que cuestionaban la internación como única respuesta frente al padecimiento psíquico. Entre ellas se destacan las Comunidades Terapéuticas en Inglaterra, la Psiquiatría Democrática Italiana impulsada por Franco Basaglia, la Psicoterapia Institucional francesa, los avances en psicofarmacología, la influencia del psicoanálisis y los movimientos de la antipsiquiatría.

En este contexto se consolidan nuevas prácticas: el trabajo interdisciplinario, la atención ambulatoria, la apertura a la comunidad y la inclusión de dispositivos alternativos al encierro. La asistencia deja de estar dirigida exclusivamente a personas con cuadros psicóticos severos y comienza a ampliarse a una multiplicidad de padecimientos, edades y contextos.

En Argentina, estas transformaciones encuentran un hito fundamental en la experiencia del Servicio de Salud Mental del Hospital de Lanús, creado en 1956 por Mauricio Goldenberg, que se convirtió en referencia internacional por su modelo de atención comunitaria, interdisciplinaria y abierta.

Es en este entramado histórico donde comienza a delinearse el surgimiento del Acompañamiento Terapéutico como una respuesta clínica novedosa, situada y necesaria.

SURGIMIENTO DE LA FIGURA DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO

El Acompañamiento Terapéutico no surge a partir de un cuerpo teórico previamente sistematizado, sino desde la práctica misma. Su aparición está íntimamente ligada a las necesidades que emergen en el trabajo cotidiano con sujetos que no encontraban respuesta suficiente en los dispositivos tradicionales.

Siguiendo a Castejón Hermann (2014), puede identificarse un proceso de transformación progresiva de la figura del auxiliar psiquiátrico hacia la del acompañante terapéutico. En un primer momento, el auxiliar cumplía funciones de control y vigilancia, pero también comenzaba a ofrecer un sostén afectivo en la vida cotidiana del paciente.

Durante las dictaduras latinoamericanas, esta figura se desplaza hacia el ámbito domiciliario, perdiendo el respaldo institucional pero ganando una inserción directa en la dinámica familiar y comunitaria. Este movimiento habilita nuevas posibilidades de intervención y posiciona al acompañante como representante de la institución en el territorio.

Entre el auxiliar psiquiátrico y el AT aparece una figura intermedia: el llamado “amigo calificado”, que expresa el intento de nombrar una práctica aún en construcción. Tal como señala Pullice (2018), fue necesario un largo proceso de maduración para que el AT pudiera diferenciarse de otras disciplinas y consolidar una identidad propia.

El AT debe pensarse, entonces, como el resultado de un entrecruzamiento histórico, político y clínico, más que como la creación de un autor o una teoría en particular. Su emergencia produce efectos en las dimensiones ética, clínica y política, haciendo necesaria la posterior elaboración teórica de esta práctica.

EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL

Fundamentos teórico–clínicos:

El Acompañamiento Terapéutico se ha instalado progresivamente en el amplio campo de la salud mental como un recurso clínico alternativo y eficaz para el abordaje de sujetos que se presentan en situaciones de vulnerabilidad, inestabilidad o desorganización psíquica, y cuyas manifestaciones exceden, en muchos casos, los dispositivos terapéuticos convencionales.

En determinadas presentaciones clínicas, cuando el padecimiento del sujeto desborda los encuadres tradicionales de atención, tanto los profesionales como las familias suelen encontrar en la internación la única respuesta posible. Esta modalidad de intervención,

muchas veces, continúa reproduciendo la lógica manicomial, en la que el encierro aparece como solución frente a lo que irrumpe como crisis.

Desde una posición ética comprometida con los derechos humanos y con la desmanicomialización de la asistencia, el Acompañamiento Terapéutico se inscribe como un dispositivo alternativo a la institucionalización crónica. En este sentido, nuestra perspectiva se enmarca explícitamente en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, que concibe la salud —y la salud mental en particular— como un derecho humano fundamental e intransferible.

El AT constituye un recurso que permite desplegar distintas modalidades de intervención orientadas a favorecer el sostenimiento y la reconstrucción de los lazos familiares, comunitarios y sociales del sujeto en tratamiento. Asimismo, posibilita la reducción de los períodos de internación, promueve procesos de estabilización subjetiva e integración social, y colabora en la prevención de nuevas crisis, siempre en el marco de estrategias interdisciplinarias.

No obstante, el Acompañamiento Terapéutico no se limita a ser un recurso complementario dentro de otros dispositivos. Con el paso del tiempo, ha ido delimitando e instituyendo un campo propio, con conceptos teóricos específicos y una práctica singular que le otorgan estatuto de dispositivo clínico complejo. Por este motivo, resulta necesario realizar una reflexión inicial sobre los fundamentos teóricos, éticos y clínicos que orientan el quehacer cotidiano de las y los acompañantes terapéuticos.

EL LUGAR DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO EN LA INTERDISCIPLINA

La práctica del Acompañamiento Terapéutico se valida teóricamente a partir de una clínica de lo cotidiano, sostenida en la acción, la tarea y la intervención situada. El encuentro entre el/la acompañante terapéutico/a y el/la sujeto acompañado/a configura un dispositivo singular que se articula con un proyecto terapéutico más amplio, enmarcado en una estrategia interdisciplinaria y orientado por el caso por caso.

Desde una perspectiva epistemológica, las ciencias son construcciones humanas y sociales que surgen para dar respuesta a problemáticas concretas de la realidad. Sin embargo, algunos saberes se instituyen como modelos hegemónicos, presentándose como incuestionables y cerrados sobre sí mismos. En contraposición, existen campos de conocimiento —como el del AT— donde sujeto y objeto se construyen mutuamente en la práctica, y donde el saber se produce en articulación con otras disciplinas.

Siguiendo a Stolkiner (1987), entendemos la interdisciplina no como una simple suma de saberes, sino como una respuesta necesaria frente a la complejidad de las demandas

actuales. Los problemas no se presentan como objetos claramente delimitados, sino como situaciones atravesadas por múltiples dimensiones biológicas, psíquicas, sociales, culturales e históricas.

En este marco, las y los acompañantes terapéuticos trabajan siempre en articulación con otros/as profesionales de la salud, formando parte de equipos interdisciplinarios que pueden incluir psicólogos/as, psiquiatras, médicos/as, trabajadores/as sociales, psicopedagogos/as, neurólogos/as, entre otros, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

La indicación de un dispositivo de AT surge, entonces, frente a demandas complejas que no pueden ser abordadas desde una única disciplina. La interdisciplina se constituye como un posicionamiento ético y clínico, que se despliega en la acción cooperativa, en el intercambio de saberes y en la construcción conjunta de estrategias de tratamiento.

Desde esta perspectiva, afirmamos que las y los acompañantes terapéuticos son agentes de salud que sostienen una autonomía relativa en sus intervenciones, siempre enmarcadas en los objetivos y lineamientos definidos junto al equipo interdisciplinario. El AT no trabaja en soledad: su práctica se apoya en un marco teórico que otorga especificidad al saber hacer, y en un equipo que sostiene, orienta y acompaña la estrategia terapéutica singular.

LA ESPECIFICIDAD DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO Y SU POSICIÓN ÉTICA

Interrogar la función y la especificidad del Acompañamiento Terapéutico implica necesariamente reflexionar sobre la posición ética desde la cual se despliegan las intervenciones. Desde nuestra cátedra, nos alejamos de concebir al AT como un dispositivo regido por esquemas rígidos o protocolos estandarizados, similares a manuales de intervención.

Siguiendo a Pulice (2016), entendemos la ética como aquello que orienta y comanda nuestro modo de hacer, nuestra manera de intervenir y de estar en el mundo. La posición ética no se reduce a un conjunto de normas, sino que constituye el trasfondo desde el cual se toman decisiones clínicas, se construyen vínculos y se asume una implicación subjetiva en el quehacer cotidiano.

En este sentido, podemos diferenciar dos posiciones éticas frente a la intervención. La primera —que aquí cuestionamos— es la del “manual del AT”, que pretende establecer de antemano cómo intervenir frente a determinadas situaciones clínicas en función de un diagnóstico. Esta posición tiende a borrar la singularidad del sujeto, reduciéndolo a una

categoría diagnóstica y proponiendo intervenciones estandarizadas, planificadas antes del encuentro.

La segunda posición ética, que sostenemos, es la que se orienta por la singularidad del caso por caso. Desde esta perspectiva, la función del/la acompañante terapéutico/a no puede definirse a priori, sino que se configura en relación con la estrategia de tratamiento, el encuadre, el momento clínico y las particularidades del sujeto acompañado.

Si bien a lo largo del tiempo se han propuesto distintas descripciones de la función del AT —contener, acompañar, modelizar, promover la creatividad—, ninguna de ellas puede tomarse como universal o definitiva. Estas coordenadas funcionan como orientaciones generales que deben ser siempre problematizadas y redefinidas en función de cada situación clínica.

El acompañamiento no se orienta a promover una adaptación pasiva a la realidad, sino a habilitar espacios donde el sujeto pueda recuperar o descubrir intereses, deseos y actividades propias, favoreciendo su protagonismo dentro de su contexto sociocultural y de acuerdo con sus posibilidades subjetivas.

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

Parafraseando a Frank y Dragotto (2017), habitamos una sociedad que tiende a igualar, homogeneizar y producir respuestas estandarizadas, en un modelo que deja poco lugar para la singularidad. En este contexto, se observa una progresiva desarticulación de la empatía y del reconocimiento del otro como sujeto, lo que impacta de manera directa en quienes atraviesan situaciones de padecimiento subjetivo.

Desde el lugar de las y los acompañantes terapéuticos como agentes de salud, sostenemos que el establecimiento de un vínculo es una condición necesaria del dispositivo AT. No se trata de un vínculo entendido como suplencia, prótesis o compensación de carencias previas, sino como un lazo que posibilite transformaciones subjetivas y la apertura hacia nuevas formas de relación.

El vínculo en el AT se construye como una apuesta a lo estable en tiempos de fragilidad y transitoriedad. Su función no es reproducir relaciones rígidas o estereotipadas que enferman, sino habilitar experiencias vinculares diferentes, que introduzcan variaciones en modos de estar con otros y consigo mismo.

Desde una posición ética, el acompañamiento se orienta a consolidar relaciones estables, seguras y confiables, que oficien como andamiajes simbólicos frente a situaciones de

vulnerabilidad. La mirada de reconocimiento se vuelve aquí un elemento central: reconocer al sujeto como tal, más allá de su diagnóstico o de su padecimiento, permite reabrir la dimensión del deseo.

Pensar el acompañamiento en términos de red implica considerar que el deseo emerge allí donde hay falta. En ese espacio, el/la acompañante terapéutico/a se posiciona como alguien dispuesto a escuchar, a sostener la palabra y a acompañar procesos de subjetivación posibles.

En un dispositivo de AT, el sujeto suele estar incluido en otros encuadres de escucha —profesionales, equipos interdisciplinarios, instituciones—. Estas presencias, en muchos casos, fundamentan la indicación de un/a o varios/as acompañantes terapéuticos/as, a partir de lo cual se diseña una estrategia singular de intervención.

No existen recetas ni pautas estandarizadas que puedan aplicarse de manera uniforme. Cada acompañamiento requiere la construcción de un ritmo propio, de un espacio-tiempo singular, que constituye el núcleo ético del acompañar. En este sentido, afirmamos que el vínculo es la principal herramienta del AT y que toda intervención debe orientarse al respeto y la ampliación de la subjetividad del/la acompañado/a, sin prejuicios ni reduccionismos.

LA PRÁCTICA COMO SABER HACER PERMANENTE

La reflexión sobre los vínculos entre teoría y práctica permite interrogar los andamiajes que sostienen la especificidad del Acompañamiento Terapéutico. La praxis del AT se entiende como la articulación constante entre los marcos teóricos y la práctica concreta en los acompañamientos, que se desarrollan en múltiples ámbitos y contextos.

Resulta relevante detenernos en la investidura simbólica del nombre “acompañamiento terapéutico”. Tal como señala Roberts (2019), el término condensa un doble movimiento: por un lado, el acompañar como presencia sostenida; por otro, lo terapéutico como orientación clínica. Esta doble dimensión delimita un modo particular de intervención que exige coordenadas propias.

En Argentina, el campo del AT se ha construido a partir del despliegue de sus prácticas, la escritura de casos clínicos, viñetas y recortes de experiencias realizadas tanto en ámbitos institucionales públicos y privados como en dispositivos domiciliarios y comunitarios. Este proceso ha sido acompañado por la producción teórica de diversos autores que han contribuido a la consolidación del campo.

Actualmente, asistimos a un momento de fortalecimiento de la identidad del AT como profesión y como dispositivo clínico. Se observa una ampliación de los campos de

intervención, avances en los marcos regulatorios, incorporación progresiva al sistema de salud pública y mayor formalización en la formación académica.

Este proceso se sostiene en un entramado teórico que articula aportes del Psicoanálisis, la Psiquiatría Dinámica, la Psicología, la Psicología Comunitaria y el enfoque de Derechos Humanos, configurando un saber propiamente AT que orienta tanto las intervenciones clínicas como el posicionamiento ético frente a los sujetos acompañados.

Las prácticas del AT pueden desplegarse en distintos ámbitos: institucionales (educativos, judiciales, hospitalarios) y ambulatorios (externaciones, internaciones domiciliarias), siempre desde una perspectiva de derechos, priorizando el trabajo interdisciplinario y el compromiso ético que atraviesa toda la práctica.

LOS INICIOS DE UN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

El inicio de un dispositivo de AT se encuentra atravesado por múltiples variables, por lo que resulta fundamental despejar y clarificar la demanda: quién solicita el acompañamiento, para qué y en qué contexto. Este trabajo inicial permite construir una demanda específica que habilite la formulación de una estrategia de intervención posible.

Definir la inclusión del AT implica articular dimensiones teóricas, éticas y prácticas, siempre con el objetivo de resguardar la singularidad del sujeto acompañado. Esto supone considerar su historia, sus padecimientos, sus tiempos subjetivos, su franja etaria y sus contextos familiares, sociales y económicos.

Desde los primeros momentos, resulta especialmente valioso contar con un equipo de AT, ya que este espacio posibilita la reflexión, el intercambio y la elaboración colectiva de la práctica. En este marco, Pullice (2018) destaca que la sola presencia del/la acompañante terapéutico/a —una presencia disponible y sostenida— produce ya efectos terapéuticos.

Los inicios del AT pueden adoptar modalidades diversas: algunos acompañamientos se inician de manera autónoma, otros en articulación directa con profesionales tratantes o con familias, y muchos dentro de equipos organizados con dispositivos de coordinación.

La figura del/la coordinador/a resulta central en la conformación de estos equipos, ya que establece pautas de trabajo, regula aspectos administrativos y clínicos, y favorece una organización que resguarda tanto al sujeto acompañado como a las y los acompañantes terapéuticos.

LA SUPERVISIÓN Y LOS ENCUENTROS EN EL AT

Pensar la práctica del AT implica reconocer la importancia de no transitarla en soledad. El inicio de los encuentros suele estar atravesado por la incertidumbre y lo inesperado, dado que intervienen múltiples miradas: la del profesional tratante, la del equipo interdisciplinario, la de la familia y la del propio sujeto acompañado.

En este contexto, la supervisión se ha consolidado como un espacio fundamental, especialmente en la articulación entre el AT y el Psicoanálisis. La supervisión se concibe como un espacio de reflexión clínica, de elaboración de dificultades y de revisión de las intervenciones.

Se trata de generar un espacio de consulta con referentes que conozcan específicamente el quehacer del AT, por fuera del dispositivo y del equipo interdisciplinario, favoreciendo una apertura libre de prejuicios que permita trabajar dudas, obstáculos, aciertos y errores de la práctica cotidiana.

LAS COMPLEJIDADES DE LA CLÍNICA DE LO COTIDIANO

La formalización teórica del AT ha sido un proceso largo, atravesado por tensiones entre la espontaneidad intuitiva y la rigidez de esquemas estandarizados. En sus inicios, muchos/as acompañantes oscilaron entre estos extremos, lo que en ocasiones desdibujó la especificidad del rol.

El AT se despliega en la cotidianeidad, en un encuadre abierto y ambulante (Dozza de Mendoca, 2014), donde los encuentros se producen en espacios públicos, con interrupciones y contingencias que forman parte de la situación clínica.

La clínica de lo cotidiano propone desenfocar al sujeto de su enfermedad para situarlo en un espacio donde la palabra y las actividades cotidianas habiliten nuevos posicionamientos subjetivos. Actividades simples —como juegos, comidas, paseos— adquieren sentidos distintos según el caso, los objetivos terapéuticos y la singularidad del sujeto.

Los paseos, por ejemplo, no deben pensarse como mero deambular, sino como estrategias clínicas que requieren planificación y articulación con el deseo del sujeto, permitiendo construir recorridos con sentido singular (Pulice, 2018).

MARCO NORMATIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO EN JUJUY

Salud mental, derechos y ejercicio profesional:

El ejercicio del Acompañamiento Terapéutico (AT) en la Argentina se inscribe en un proceso histórico atravesado por profundas transformaciones en el campo de la salud mental. Tal como se desarrolló en los temas anteriores de esta cartilla, el AT surge como una práctica clínica y comunitaria que cuestiona el modelo manicomial y propone intervenciones situadas en la vida cotidiana, los vínculos y el territorio. En este marco, el conocimiento de las leyes que regulan la salud mental y el ejercicio profesional del AT constituye un eje fundamental en la formación de quienes ingresan a la carrera.

En la provincia de Jujuy, el marco normativo que regula y orienta la práctica del acompañamiento terapéutico se encuentra conformado por la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, la Ley Provincial N.º 5937 de adhesión a dicha normativa y la Ley Provincial N.º 6262 de Ejercicio Profesional del Acompañante Terapéutico. Estas leyes no solo delimitan derechos y obligaciones, sino que expresan un posicionamiento ético y político frente al padecimiento psíquico y las formas de intervención en salud mental.

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 fue sancionada en el año 2010 y representa un cambio de paradigma en el abordaje del sufrimiento psíquico en la Argentina. Esta ley concibe la salud mental como un proceso determinado por múltiples factores —biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos— y la reconoce como un derecho humano fundamental.

Entre sus principios centrales se destacan la desmanicomialización, la prioridad de los tratamientos ambulatorios y comunitarios, el trabajo interdisciplinario y la participación activa de las personas en las decisiones sobre su tratamiento. Desde este enfoque, se promueve la sustitución progresiva de los hospitales monovalentes por dispositivos alternativos que favorezcan la inclusión social y el fortalecimiento del lazo comunitario.

El acompañamiento terapéutico encuentra en esta ley un respaldo fundamental, ya que se trata de un dispositivo clínico que interviene en la vida cotidiana del sujeto, favoreciendo procesos de externación, sostén vincular, prevención de recaídas y construcción de autonomía posible.

La Ley Provincial N.º 5937: adhesión de Jujuy a la Ley Nacional de Salud Mental

La provincia de Jujuy adhiere a la Ley Nacional de Salud Mental mediante la **Ley Provincial Nº 5937**, sancionada el **6 de julio de 2016** y promulgada el **20 de julio de 2016**. Esta adhesión implica la incorporación de los principios de la Ley 26.657 al sistema de salud provincial y establece el compromiso del Estado jujeño con un modelo de atención en salud mental basado en derechos humanos.

Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran la creación del Órgano Provincial de Revisión en Salud Mental y la obligación de promover dispositivos de atención comunitaria, interdisciplinares y respetuosos de la singularidad de cada sujeto. Este marco habilita y legitima la inclusión del AT como recurso clínico dentro de las estrategias de tratamiento en la provincia.

La Ley Provincial N.º 6262: ejercicio profesional del Acompañante Terapéutico en Jujuy

La Ley Provincial N.º 6262 regula específicamente el ejercicio profesional del Acompañante Terapéutico en Jujuy. Su sanción constituye un avance significativo en términos de reconocimiento legal y profesional del AT como agente de salud con formación específica.

Esta normativa define las funciones, incumbencias, derechos y obligaciones del acompañante terapéutico, establece criterios de formación y regula su inserción tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, refuerza la necesidad de que el AT trabaje articuladamente con equipos interdisciplinarios, en coherencia con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental.

La Ley 6262 no sustituye a las leyes de salud mental, sino que las complementa, aportando un marco específico que contribuye a la consolidación de la identidad profesional del AT en el territorio jujeño.

La realidad del AT en Jujuy: tensiones entre la norma y la práctica

A pesar de los avances normativos, la práctica cotidiana del acompañamiento terapéutico en Jujuy continúa atravesada por tensiones históricas. La existencia de leyes no garantiza por sí misma la implementación efectiva de políticas públicas que aseguren condiciones laborales, institucionales y formativas acordes a la complejidad de la tarea.

La creciente demanda de acompañantes terapéuticos, en consonancia con el paradigma comunitario y de derechos, no siempre se acompaña de recursos suficientes, espacios

sistemáticos de supervisión, inserción estable en el sistema de salud ni reconocimiento pleno dentro de las prestaciones. Esta brecha entre lo legal y lo real constituye un desafío central para el campo del AT.

Asimismo, la regulación del ejercicio profesional visibiliza la coexistencia de distintas trayectorias formativas, reconociendo prácticas históricas previas y, al mismo tiempo, promoviendo procesos de profesionalización académica. Este escenario refuerza la importancia de una formación sólida, ética y reflexiva para quienes ingresan a la carrera.

Dimensión ética del ejercicio profesional

El marco legal vigente en Jujuy contribuye a fortalecer el encuadre ético del acompañamiento terapéutico, estableciendo límites claros en relación con las funciones y responsabilidades del AT. Sin embargo, la ética del acompañar no se sostiene únicamente en la ley, sino en el modo de intervenir, en el trabajo interdisciplinario, en la supervisión y en la capacidad de alojar la singularidad del sujeto.

Desde esta perspectiva, el AT no es un recurso asistencial ni un dispositivo de control, sino una práctica clínica y comunitaria orientada a promover derechos, sostener el lazo social y acompañar procesos subjetivos singulares.

El acompañamiento terapéutico en Jujuy se encuentra en un proceso de consolidación, atravesado por avances normativos significativos y desafíos pendientes en su implementación. La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 (2010), la Ley Provincial N.º 5937 (2016) y la Ley Provincial N.º 6262 constituyen un entramado legal que respalda y orienta la práctica del AT.

Para quienes hoy inician su formación como acompañantes terapéuticos, el conocimiento de este marco normativo resulta indispensable. No se trata solo de conocer leyes, sino de comprender que el ejercicio del AT implica asumir una práctica ética, situada y comprometida con la salud mental comunitaria y los derechos humanos en el contexto específico de la provincia de Jujuy.

¿QUE LEYES SON IMPORTANTES CONOCER COMO ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO?

-LEY Nº 26 657 SALUD PÚBLICA SALUD MENTAL.

https://www.youtube.com/watch?v=qWDg8jGNn5s

-LEY PROVINCIAL

https://drive.google.com/file/d/1IUkJx1Pq3WK0mpvTvz__oG97dHySKxx8/view?usp=drive_link

-CODIGO AATRA

https://drive.google.com/file/d/1vzHElocxLF4a9qwJ2D4bLIWRpQUKhtQM/view?usp=drive_link

Referencias Bibliográficas

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1997). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu.
- Bleichmar, S. (2005). *Avatares del sujeto y del vínculo. Clínica psicoanalítica contemporánea*. Paidós.
- Bleichmar, S. (2007). *Clínica del sufrimiento psíquico. El malestar en la cultura contemporánea*. Paidós.
- Castejón Hermann, M. (2014). *Acompañamiento terapéutico y psicosis: Articulador de lo real, simbólico e imaginario*. Letra Viva.
- Del Cueto, A. M. (2014). *La salud mental comunitaria: Vivir, pensar, desear*. Fondo de Cultura Económica.
- Dozza de Mendonça, L. (2014). *Acompañamiento terapéutico y clínica de lo cotidiano*. Letra Viva.
- Dragotto, P., & Frank, L. (2017). Ética y acompañamiento terapéutico. En *Acompañantes terapéuticos: Conceptualizaciones y experiencias* (pp. 45–60). Brujas.
- Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. (2010). *Salud pública – Salud mental*. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley Provincial N.º 5937. (2016). *Adhesión de la Provincia de Jujuy a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657*. Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy.
- Ley Provincial N.º 6262. (s. f.). *Ejercicio profesional del acompañante terapéutico en la Provincia de Jujuy*. Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy.

- Pulice, G. (2016). *Fundamentos clínicos del acompañamiento terapéutico*. Letra Viva.
- Pulice, G. (2018). *Acompañamiento terapéutico, transferencia y dirección de la cura: Fundamentos éticos de su clínica*. Letra Viva.
- Roberts, H. (2019). Acerca del nombre propio, la formación académica del acompañamiento terapéutico y la epistemología del campo. En *Actas del XV Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico* (pp. 1–8). Rosario, Argentina.
- Roberts, H., & Oppedisano, P. (2013). *Sobre la iniciación del acompañamiento terapéutico*. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. En *El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio* (pp. 301–320). Nueva Visión.

EJE VI:

BASES BIOLOGICAS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO:

ORIGEN DE LA CONCEPCIÓN DE SUJETO:

De lo biológico al sujeto humano

La concepción y el nacimiento: el inicio de la vida humana

La concepción y el nacimiento constituyen acontecimientos biológicos fundamentales que marcan el inicio de la vida humana y ubican al individuo dentro de la especie. Desde esta perspectiva, el ser humano comparte con otros seres vivos una base biológica común, resultado de un largo proceso evolutivo que permitió el desarrollo de adaptaciones necesarias para la supervivencia.

A lo largo de su historia evolutiva, la especie humana produjo transformaciones que reorganizaron su estructura morfofisiológica y posibilitaron un intercambio cada vez más complejo con el medio. Uno de los rasgos distintivos del ser humano, en tanto organismo vivo, es su capacidad de **auto organización**, es decir, la posibilidad de construir y reconstruir su funcionamiento a partir de la energía, los recursos y la información que obtiene del entorno.

Esta capacidad de auto organización permite al organismo mantener su equilibrio interno y adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. Sin embargo, dicha autonomía no implica independencia absoluta.

Autonomía y dependencia: una tensión constitutiva

La vida humana se sostiene en una tensión permanente entre autonomía y dependencia. Para poder organizarse y sostener su funcionamiento, el organismo necesita del medio natural, social y cultural. La dependencia del entorno no anula la autonomía, sino que la hace posible.

Como señala Edgar Morin, todo organismo vivo es simultáneamente **producto y productor**: es producto de un proceso de reproducción biológica, pero también es productor de sí mismo, participando activamente en su propia organización. Esta lógica resulta central para comprender al ser humano no como un ente pasivo, sino como un sistema dinámico en constante interacción con su entorno.

Del organismo al sujeto: la constitución subjetiva

Ahora bien, devenir sujeto no es un proceso exclusivamente biológico. Si bien la vida comienza con una dotación genética y orgánica, la constitución del sujeto implica un proceso complejo que excede lo biológico.

El sujeto humano no está dado de antemano en la biología. Se constituye progresivamente en la relación con otros, a través de los vínculos, el lenguaje, la cultura y la inscripción en un entramado social e histórico. En este proceso se construyen el yo, la identidad, el reconocimiento del otro y la conciencia de sí.

Desde esta perspectiva, el pasaje del organismo al sujeto implica una transformación cualitativa: el cuerpo biológico se convierte en un cuerpo vivido, habitado por significaciones, afectos y experiencias. El desarrollo humano no puede pensarse únicamente en términos de maduración orgánica, sino como un proceso relacional y simbólico.

Especie, individuo y singularidad

La relación entre especie e individuo puede pensarse como complementaria. El individuo pertenece a una especie y hereda una base biológica común, pero al mismo tiempo desarrolla una trayectoria singular, irrepetible, construida a partir de sus experiencias, vínculos y condiciones de existencia.

Esta mirada permite alejarse de concepciones reduccionistas que explican la conducta humana únicamente desde lo biológico o lo genético. La biología establece condiciones de posibilidad, pero no determina de manera rígida la subjetividad ni la conducta.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Para el Acompañante Terapéutico, comprender esta articulación entre organismo, sujeto, autonomía y dependencia resulta fundamental. El AT trabaja con personas cuya autonomía se encuentra, en distintos momentos, comprometida o en proceso de construcción, y cuya singularidad se expresa en formas diversas de habitar el cuerpo, el vínculo y el mundo.

Desde esta perspectiva, el acompañamiento no apunta a “normalizar” conductas, sino a **sostener procesos**, favorecer condiciones de regulación, promover la autonomía posible y respetar los tiempos subjetivos de cada persona.

Entender al ser humano como un sujeto en construcción permanente constituye un principio ético y clínico central del Acompañamiento Terapéutico en Argentina.

Genética, epigenética y singularidad

Bases biológicas y construcción de la diferencia subjetiva

La célula como unidad básica de la vida

La célula constituye la unidad estructural y funcional básica de todos los seres vivos. El organismo humano está conformado por billones de células que, aunque comparten la misma información genética, se diferencian en su forma y función. Algunas células brindan sostén, otras participan del movimiento, de la transmisión nerviosa, de la defensa inmunológica o de la secreción hormonal.

Esta diferenciación celular permite el funcionamiento integrado del cuerpo humano y constituye la base biológica sobre la cual se desarrollan los procesos fisiológicos, emocionales y cognitivos.

Cada célula contiene el material genético del organismo, responsable de transmitir la información necesaria para el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento de la vida. Además, posee la capacidad de reproducirse, permitiendo la renovación de tejidos y la continuidad del organismo.

El material genético y el genoma humano

En el interior de la célula se encuentra el núcleo, considerado el centro de control celular. Allí se aloja el ADN (ácido desoxirribonucleico), organizado en 23 pares de cromosomas, lo que conforma un total de 46 cromosomas en las células humanas. De estos, 22 pares son autosómicos y un par corresponde a los cromosomas sexuales (XX o XY).

El ADN contiene aproximadamente 20.000 genes, que codifican proteínas y regulan múltiples procesos biológicos. El conjunto completo de esta información genética recibe el nombre de **genoma**.

El genoma puede pensarse como un programa biológico que orienta el desarrollo y funcionamiento del organismo. Sin embargo, este programa no actúa de manera rígida ni determina por sí solo la conducta, la subjetividad o el destino del sujeto.

Es importante subrayar que todos los seres humanos comparten una estructura genética común y que las diferencias individuales no se explican exclusivamente por los genes.

Herencia mendeliana: principios básicos de transmisión genética

La herencia mendeliana describe los patrones generales mediante los cuales ciertos rasgos se transmiten de una generación a otra. Estos principios fueron formulados por Gregor Mendel en el siglo XIX y constituyen la base de la genética clásica.

Mendel formuló tres leyes fundamentales:

1. **Ley de la uniformidad**
   Al cruzar dos individuos genéticamente puros, la primera generación filial presenta características homogéneas.
2. **Ley de la segregación**
   Los pares de alelos se separan durante la formación de los gametos, de modo que cada gameto recibe un solo alelo de cada par.
3. **Ley de la combinación independiente**
   Los rasgos se transmiten de manera independiente unos de otros, siempre que se encuentren en cromosomas distintos.

Estos modelos explican adecuadamente la transmisión de rasgos simples. Sin embargo, en los seres humanos muchos rasgos físicos, conductuales y psíquicos no responden a estos patrones estrictos.

Existen fenómenos como la dominancia intermedia y la codominancia, así como rasgos poligénicos y multifactoriales, lo que demuestra que la genética mendeliana resulta necesaria pero insuficiente para comprender la complejidad de la conducta humana y del padecimiento psíquico.

Epigenética: genes en interacción con el ambiente

La epigenética estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Es decir, analiza cómo determinados genes pueden activarse o desactivarse en función de condiciones ambientales, experiencias vitales y contextos vinculares.

Estos mecanismos incluyen procesos como la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas, que funcionan como reguladores de la expresión génica.

Factores tales como:

- El ambiente familiar,
- Las experiencias tempranas,

- El estrés crónico,
- Los vínculos afectivos,
- Las condiciones sociales, culturales y económicas, pueden influir de manera significativa en la forma en que la información genética se expresa a lo largo de la vida.

Desde esta perspectiva, los genes no actúan de manera aislada ni determinista, sino en constante interacción con el entorno.

Modelos multicausales y padecimiento psíquico

Numerosos trastornos del neurodesarrollo y del campo de la salud mental responden a modelos multicausales, en los que intervienen múltiples genes junto con factores ambientales y relacionales.

Condiciones como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el TDAH presentan componentes hereditarios importantes, pero su manifestación clínica depende de complejas interacciones entre biología, ambiente, historia vincular y contexto social.

Este enfoque permite abandonar explicaciones simplistas y sostener una mirada clínica más compleja e integrada.

Singularidad y relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

El enfoque genético y epigenético permite sostener una mirada no reduccionista sobre la conducta humana. La biología aporta condiciones de posibilidad, pero no fija destinos cerrados.

Para el Acompañante Terapéutico, esta perspectiva resulta fundamental porque:

- Evita interpretar la conducta como producto exclusivo de la herencia genética,
- Permite comprender el impacto del ambiente y los vínculos en el desarrollo subjetivo,
- Habilita una lectura más compleja del padecimiento psíquico,
- Sostiene intervenciones centradas en la singularidad del sujeto y no en el diagnóstico Aislado.

Desde este marco, la conducta no es un destino genético, sino el resultado de una trama dinámica entre lo biológico, lo vincular, lo social y lo histórico. Este principio constituye un eje ético y clínico central en la práctica del Acompañamiento Terapéutico

Neurodesarrollo y plasticidad cerebral

Del desarrollo biológico a la experiencia subjetiva

El neurodesarrollo como proceso dinámico

El neurodesarrollo refiere al conjunto de procesos mediante los cuales se forma, organiza y transforma el sistema nervioso a lo largo de la vida. Este proceso comienza pocos días después de la concepción y se extiende, al menos, hasta la adultez temprana, aproximadamente entre los 20 y 25 años, período en el que se completa la maduración de áreas cerebrales vinculadas al control de impulsos, la planificación y la regulación emocional.

Sin embargo, los avances de la neurociencia contemporánea permiten afirmar que el sistema nervioso conserva capacidad de cambio durante toda la vida. Por ello, el neurodesarrollo no debe pensarse como una etapa cerrada exclusivamente en la infancia, sino como un proceso continuo, dinámico y abierto a transformaciones.

Esta concepción resulta especialmente relevante para el campo del Acompañamiento Terapéutico, ya que habilita intervenciones sostenidas en la posibilidad de cambio, aun en contextos de alta vulnerabilidad.

Etapas del neurodesarrollo

El desarrollo del sistema nervioso incluye etapas prenatales y posnatales que se articulan entre sí.

Etapa prenatal

Durante la etapa embrionaria y fetal se producen procesos fundamentales para la organización del sistema nervioso:

- Proliferación neuronal,
- Migración de las neuronas hacia sus ubicaciones definitivas,
- Diferenciación celular,

- Organización inicial de los circuitos neuronales.

A partir de una única célula (la cigota), se configura progresivamente el cerebro humano, ya claramente diferenciado del de otras especies al momento del nacimiento.

Etapa posnatal

Luego del nacimiento, el sistema nervioso continúa su desarrollo mediante procesos como:

- Formación y fortalecimiento de conexiones sinápticas,
- Poda sináptica (eliminación de conexiones poco utilizadas),
- Mielinización de los axones,
- Reorganización funcional de las redes neuronales.

Estos procesos se extienden a lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud, y se expresan en cambios observables en la conducta, el aprendizaje, la regulación emocional y la capacidad de vínculo.

Principios fundamentales del neurodesarrollo

A partir de los aportes de la neurociencia actual, pueden destacarse algunos principios centrales:

- El neurodesarrollo abarca un período mucho más amplio de lo que tradicionalmente se pensaba, incluyendo la adolescencia y la adultez temprana.
- Existen continuidades entre el desarrollo prenatal y posnatal: muchos procesos comienzan antes del nacimiento y se completan años después.
- La ontogenia constituye el fenómeno de plasticidad más masivo del sistema nervioso, ya que permite el pasaje desde una célula única a un órgano de extrema complejidad.
- El desarrollo cerebral es el resultado de la interacción constante entre la dotación genética y las experiencias del ambiente.

Estos principios refuerzan la idea de que el cerebro humano no se desarrolla de manera automática ni predeterminada, sino en estrecha relación con los vínculos, el entorno y las condiciones de vida.

Plasticidad cerebral: posibilidad de cambio y reorganización

La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para modificarse estructural y funcionalmente en respuesta a la experiencia. Gracias a esta propiedad, el cerebro puede:

- Aprender nuevas habilidades,
- Adaptarse a contextos cambiantes,
- Reorganizar funciones frente a lesiones o déficits,
- Incorporar experiencias vinculares significativas.

La plasticidad es especialmente intensa durante la infancia y la adolescencia, pero no desaparece en la adultez. Los aprendizajes, los tratamientos terapéuticos, el acompañamiento sostenido y los contextos facilitadores pueden promover cambios reales en el funcionamiento cerebral.

Desde esta perspectiva, el diagnóstico no define de manera absoluta las posibilidades del sujeto, sino que describe un estado en un momento determinado de su historia.

Neurodesarrollo, experiencia y subjetividad

El neurodesarrollo no puede pensarse únicamente como un proceso biológico. La organización del sistema nervioso está profundamente influenciada por la experiencia subjetiva, los vínculos tempranos, el lenguaje, la cultura y las condiciones sociales.

Las experiencias de cuidado, sostén, reconocimiento o, por el contrario, de abandono, violencia o exclusión, dejan huellas en la organización neurobiológica y emocional del sujeto. Estas huellas no son inmutables, pero sí influyen en la forma en que el sujeto se vincula consigo mismo y con los otros.

En este sentido, el desarrollo cerebral y la constitución subjetiva se encuentran estrechamente articulados.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Comprender el neurodesarrollo y la plasticidad cerebral permite al Acompañante Terapéutico:

- Leer la conducta como expresión de procesos en desarrollo y no como fallas personales,
- Reconocer los tiempos subjetivos y neurobiológicos del sujeto acompañado,

  Sostener intervenciones ajustadas a las posibilidades reales de cada persona,

- Trabajar desde una perspectiva que integra cuerpo, emoción, pensamiento y contexto.

Desde este enfoque, el acompañamiento terapéutico no apunta a "corregir conductas", sino a favorecer condiciones de regulación, aprendizaje y reorganización subjetiva, apoyándose en la plasticidad cerebral y en la potencia transformadora de los vínculos.

Organización general del Sistema Nervioso

Bases neurobiológicas de la conducta, la emoción y el pensamiento

El Sistema Nervioso como sistema de regulación e integración

El Sistema Nervioso, en estrecha articulación con el sistema endocrino, constituye el principal sistema de regulación y coordinación del organismo. A través de ambos sistemas se organizan tanto las actividades conscientes —como el pensamiento, el lenguaje y el movimiento voluntario— como las actividades inconscientes o involuntarias —como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la secreción hormonal—.

El sistema nervioso recibe información del medio interno y externo, la procesa, la integra y genera respuestas que permiten la adaptación del organismo a las demandas del entorno. Estas respuestas no son meramente reflejas, sino que se encuentran moduladas por la experiencia, la historia subjetiva y los vínculos.

Desde la perspectiva del Acompañamiento Terapéutico, comprender esta organización permite leer la conducta como expresión de procesos complejos, y no como actos aislados o puramente voluntarios.

División general del Sistema Nervioso

Desde un punto de vista anatómico y funcional, el sistema nervioso se organiza en dos grandes componentes:

Sistema Nervioso Central (SNC)

El Sistema Nervioso Central está conformado por:

- El encéfalo,
- La médula espinal.

Constituye el centro de integración y procesamiento de la información. En él se organizan las funciones más complejas del organismo, incluyendo la percepción, el movimiento, la emoción, la memoria y el pensamiento.

Sistema Nervioso Periférico (SNP)

El Sistema Nervioso Periférico está compuesto por los nervios que conectan el Sistema Nervioso Central con el resto del cuerpo. Su función es permitir:

- La transmisión de información sensorial desde los receptores al SNC,
- El envío de órdenes motoras y reguladoras desde el SNC hacia músculos y glándulas.

El SNP actúa como una red de comunicación que posibilita la relación constante entre el organismo y su entorno.

Funciones esenciales del Sistema Nervioso Central

El Sistema Nervioso Central cumple tres funciones fundamentales:

Detección de estímulos

Capta información proveniente tanto del medio externo (sonidos, imágenes, temperatura, contacto) como del medio interno (dolor, hambre, tensión corporal, estados fisiológicos). Esta información constituye la base de la experiencia perceptiva y corporal del sujeto.

Transmisión de la información

La información es conducida a través de circuitos neuronales altamente organizados que permiten su integración, modulación y transformación. El sistema nervioso no se limita a transmitir datos, sino que los selecciona, jerarquiza y resignifica.

Coordinación general de la conducta

El SNC organiza respuestas adaptativas que incluyen movimientos, emociones, pensamientos y regulaciones fisiológicas. Estas respuestas se ajustan a las demandas del entorno y a la historia subjetiva del individuo.

Una analogía frecuente compara al sistema nervioso con un sistema informático: los sentidos funcionarían como dispositivos de entrada, los nervios como vías de transmisión y el cerebro como una unidad central de procesamiento. Sin embargo, a diferencia de cualquier máquina, el cerebro humano posee una capacidad extraordinaria de plasticidad, autorregulación y construcción subjetiva.

El Sistema Nervioso y la experiencia subjetiva

Si bien el sistema nervioso tiene una base biológica, su funcionamiento no puede comprenderse al margen de la experiencia. Los circuitos neuronales se organizan y reorganizan en función de los aprendizajes, los vínculos, el lenguaje y las condiciones sociales.

Esto implica que la conducta no es una respuesta automática a un estímulo, sino el resultado de una compleja interacción entre:

- La estructura neurobiológica,
- La historia de experiencias del sujeto,
- Los vínculos significativos,
- El contexto social y cultural.

Esta mirada resulta fundamental para el Acompañamiento Terapéutico, ya que permite intervenir sin reducir al sujeto a su diagnóstico, a su lesión o a su síntoma.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Comprender la organización general del sistema nervioso permite al AT:

- Interpretar la conducta como expresión de procesos integrados y no fragmentados,
- Reconocer la interacción entre cuerpo, emoción y pensamiento,
- Acompañar procesos de regulación y desregulación sin moralizar la conducta,
- Sostener intervenciones acordes a las posibilidades reales del sujeto.

Desde este enfoque, el acompañamiento terapéutico se posiciona como un dispositivo que interviene sobre la experiencia cotidiana del sujeto, generando condiciones que favorecen la integración, la regulación y la construcción de nuevas formas de estar en el mundo.

Neuronas, sinapsis y neurotransmisores

La base neurobiológica de la comunicación y la conducta

Las neuronas como unidades funcionales del sistema nervioso

Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información, permitiendo la coordinación de las funciones corporales, emocionales y cognitivas.

El sistema nervioso humano está constituido por miles de millones de neuronas que no actúan de manera aislada, sino organizadas en redes complejas. Estas redes se modifican permanentemente en función de la experiencia, el aprendizaje y los vínculos, lo que constituye la base neurobiológica de la plasticidad cerebral.

Desde la perspectiva del Acompañamiento Terapéutico, esto implica que la conducta es siempre el resultado de procesos dinámicos y no de mecanismos rígidos o inmodificables.

Estructura básica de la neurona

Cada neurona presenta una estructura característica que le permite cumplir su función comunicativa:

- **Cuerpo celular o soma:**
  Contiene el núcleo y los organelos necesarios para el mantenimiento de la célula. Integra la información que recibe desde otras neuronas y determina la respuesta que será transmitida.
- **Dendritas:**
  Son prolongaciones ramificadas que reciben señales provenientes de otras neuronas. Funcionan como estructuras receptoras, permitiendo que una neurona reciba información de múltiples fuentes.
- **Axón:**
  Es una prolongación única, generalmente larga, que conduce el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Muchos axones están recubiertos por mielina, una sustancia que acelera la transmisión del impulso nervioso y mejora la eficiencia de la comunicación neuronal.

Esta organización permite que la información circule de manera direccional y organizada dentro del sistema nervioso.

La sinapsis: espacio de comunicación neuronal

La sinapsis es el proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra. No se trata de un contacto físico directo, sino de un espacio funcional que permite la transmisión de la información.

En el sistema nervioso humano predomina la **sinapsis química**, que se desarrolla a través de los siguientes pasos:

1. El impulso nervioso llega al extremo del axón (terminal presináptica).
2. Se liberan neurotransmisores al espacio sináptico.
3. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos de la neurona postsináptica.
4. Se genera una respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria.

Este mecanismo permite que la información no se transmita de forma automática, sino modulada. La neurona receptora puede amplificar, inhibir o integrar múltiples señales antes de responder.

Esta capacidad de modulación es fundamental para comprender la regulación de la conducta, las emociones y los procesos cognitivos.

Neurotransmisores y regulación del funcionamiento psíquico

Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la transmisión de la información entre neuronas. El equilibrio entre los distintos neurotransmisores resulta esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y para la estabilidad emocional y conductual.

Entre los principales neurotransmisores se destacan:

- **Acetilcolina:**
  Interviene en la contracción muscular, la memoria y la atención. También cumple un rol central en funciones del sistema nervioso autónomo.
- **Dopamina:**
  Participa en el control del movimiento, la motivación, el placer y el sistema de recompensa. Alteraciones en los circuitos dopaminérgicos se asocian a trastornos del movimiento, del estado de ánimo y a conductas adictivas.
- **Noradrenalina:**
  Se vincula con la respuesta al estrés, la vigilancia, la atención y la activación general del organismo. Su acción está estrechamente relacionada con el sistema nervioso simpático.
- **Serotonina:**
  Regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la impulsividad. Alteraciones en su funcionamiento se asocian a depresión, ansiedad y trastornos del sueño.
- **GABA (ácido gamma-aminobutírico):**
  Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Permite disminuir la excitación excesiva y regular la ansiedad.
- **Glutamato:**
  Es el principal neurotransmisor excitatorio. Cumple un rol central en el aprendizaje, la memoria y la plasticidad sináptica.

- **Endorfinas:**
  Están asociadas al alivio del dolor, el bienestar y el placer. Participan en la regulación emocional y en la respuesta al estrés.

Es importante subrayar que ningún neurotransmisor actúa de manera aislada. La conducta y la experiencia subjetiva resultan del equilibrio dinámico entre múltiples sistemas neuroquímicos.

Relevancia clínica para el Acompañamiento Terapéutico

Comprender el funcionamiento de las neuronas, la sinapsis y los neurotransmisores permite al AT:

- Leer la conducta y la desregulación emocional como procesos neurobiológicos y vinculares,
- Evitar interpretaciones moralizantes o voluntaristas del comportamiento,
- Comprender el impacto de la medicación psicotrópica sin asumir un rol prescriptivo,
- Observar cambios conductuales como indicadores de regulación o desregulación neuropsíquica.

Desde esta perspectiva, el acompañamiento terapéutico se orienta a favorecer condiciones de regulación, aprendizaje y reorganización, sosteniéndose en la plasticidad del sistema nervioso y en la potencia del vínculo terapéutico.

Sistema Nervioso Central

Estructuras y funciones principales

El Sistema Nervioso Central (SNC) constituye el principal centro de control, integración y coordinación del organismo. En articulación con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, el SNC organiza tanto las funciones conscientes como las involuntarias, posibilitando la adaptación del sujeto a las demandas internas y externas.

Desde una perspectiva clínica, el SNC no puede comprenderse únicamente como un conjunto de estructuras anatómicas, sino como un sistema dinámico, plástico y en permanente interacción con la experiencia, los vínculos y el contexto sociocultural.

Médula espinal

La médula espinal es una estructura alargada que se extiende desde el tronco encefálico hasta la región lumbar, alojada dentro de la columna vertebral. Cumple funciones esenciales para la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Funciones principales de la médula espinal

- **Transmisión de información:**
  Conduce impulsos nerviosos entre el encéfalo y los órganos periféricos. La información sensorial asciende hacia el cerebro, mientras que las órdenes motoras y reguladoras descienden hacia músculos y glándulas.
- **Coordinación de actos reflejos:**
  Permite respuestas rápidas, automáticas e involuntarias frente a determinados estímulos, sin mediación consciente del cerebro. Estos reflejos cumplen una función protectora y adaptativa (por ejemplo, retirar la mano ante un estímulo doloroso).

Para el Acompañante Terapéutico, comprender el funcionamiento reflejo resulta relevante para diferenciar conductas voluntarias de respuestas automáticas, especialmente en situaciones de dolor, sobresalto o desregulación emocional intensa.

Encéfalo

El encéfalo se encuentra alojado en la cavidad craneana y está conformado por diversas estructuras altamente especializadas, que trabajan de manera integrada.

Tronco encefálico

El tronco encefálico regula funciones vitales básicas indispensables para la supervivencia, tales como:

- La respiración,
- La frecuencia cardíaca,
- La presión arterial,
- El nivel general de conciencia.

Además, actúa como vía de paso de la información entre el cerebro y la médula espinal. Alteraciones en esta estructura pueden generar compromisos severos en la regulación del organismo.

Cerebelo

El cerebelo interviene principalmente en:

- La coordinación de los movimientos,
- El equilibrio y la postura,
- El ajuste fino de la actividad motora.

Investigaciones actuales han demostrado que también participa en funciones cognitivas y emocionales, como la atención, la planificación y la regulación afectiva. Esto permite comprender por qué alteraciones cerebelosas pueden impactar no solo en el movimiento, sino también en la conducta y la expresión emocional.

Diencéfalo

El diencéfalo alberga estructuras clave para la regulación sensorial, emocional y hormonal.

- **Tálamo:**
  Funciona como una estación de relevo de la información sensorial. Casi todos los estímulos sensoriales (excepto el olfato) pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral.
- **Hipotálamo:**
  Es una estructura central en la regulación del equilibrio interno del organismo. Coordina funciones como:

  -La temperatura corporal

  -El hambre y la sed,

  -El sueño y la vigilia,

  -La respuesta al estrés,

  -La conducta sexual,

-Los estados emocionales.

Además, el hipotálamo actúa como puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, regulando la actividad de la hipófisis.

- **Hipófisis:**
  Es la glándula principal del sistema endocrino. Libera hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas del organismo, mediante mecanismos de retroalimentación.

Para el AT, estas estructuras resultan fundamentales para comprender la relación entre emoción, cuerpo, conducta y regulación fisiológica.

Cerebro y corteza cerebral

El cerebro representa el mayor desarrollo evolutivo del sistema nervioso humano. Su superficie externa, la **corteza cerebral**, está altamente plegada y se divide en dos hemisferios y en distintos lóbulos:

- **Lóbulo frontal:** Vinculado a la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, la regulación de la conducta y la personalidad.
- **Lóbulo parietal:** Relacionado con la integración sensorial y la percepción corporal.
- **Lóbulo temporal:** Involucrado en la audición, la memoria y aspectos del lenguaje.
- **Lóbulo occipital:** Especializado en el procesamiento de la información visual.

Estas áreas permiten funciones superiores como el lenguaje, el pensamiento abstracto, la anticipación, la autorregulación y la vida simbólica.

Localización funcional y plasticidad cerebral

Si bien existen áreas cerebrales con funciones específicas, la localización funcional no es rígida ni absoluta. Gracias a la plasticidad cerebral, el sistema nervioso puede reorganizarse frente a:

- Lesiones,
- Aprendizajes,

- Experiencias vinculares,
- Intervenciones terapéuticas.

Esta capacidad de reorganización es mayor cuando existen contextos facilitadores y vínculos significativos, aspecto central para el trabajo del Acompañamiento Terapéutico.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

El conocimiento del Sistema Nervioso Central permite al AT:

- Comprender la conducta como expresión de procesos neurobiológicos complejos,
- Reconocer límites y posibilidades reales del sujeto acompañado,
- Leer desorganizaciones conductuales como manifestaciones de desregulación y no como actos intencionales,
- Sostener una práctica basada en la posibilidad de cambio y reorganización.

Desde esta perspectiva, el AT no trabaja sobre órganos aislados, sino con sujetos cuya experiencia integra cuerpo, emoción, pensamiento y contexto, en un proceso dinámico y singular.

Sistema límbico y sistema reticular

Emoción, memoria, conciencia y disponibilidad vincular

El sistema límbico y el sistema reticular constituyen dos conjuntos funcionales centrales para comprender la regulación emocional, los estados de conciencia, la memoria y la conducta. Estas estructuras se sitúan filogenéticamente entre las áreas más primitivas del cerebro y las más evolucionadas, funcionando como sistemas de articulación entre lo corporal, lo emocional y lo cognitivo.

Desde una perspectiva clínica, ambos sistemas permiten comprender por qué determinadas experiencias emocionales impactan de manera directa en la conducta, la atención, el sueño y la capacidad de establecer vínculos.

Sistema límbico

Regulación emocional, memoria y motivación

El sistema límbico está conformado por un conjunto de estructuras cerebrales ubicadas bajo la corteza cerebral, alrededor del tálamo. Su función principal es regular las respuestas emocionales, la motivación, la memoria y los comportamientos vinculados a la supervivencia y al vínculo con los otros.

Entre sus componentes más relevantes se destacan:

Hipocampo

El hipocampo cumple un rol fundamental en la memoria y el aprendizaje. Permite:

- La consolidación de la memoria a largo plazo,
- La contextualización de las experiencias,
- La organización temporal y espacial de los recuerdos.

Alteraciones en esta estructura se asocian a dificultades en el aprendizaje, desorientación y problemas en la regulación del estrés. El estrés crónico puede afectar el funcionamiento del hipocampo, lo que explica la relación entre situaciones traumáticas y dificultades mnésicas.

Amígdala cerebral

La amígdala participa activamente en el procesamiento de las emociones, especialmente aquellas vinculadas al miedo, la amenaza, la agresividad y la defensa. También cumple un papel central en la memoria emocional, es decir, en el registro afectivo de las experiencias.

Las investigaciones de Joseph LeDoux demostraron que existen dos vías de procesamiento emocional:

- **Vía larga o cortical:**
  La información sensorial pasa por la corteza cerebral, permitiendo una evaluación más reflexiva y consciente de la situación.
- **Vía corta o rápida:**
  La información va directamente del tálamo a la amígdala, generando respuestas emocionales inmediatas, sin mediación consciente.

Este mecanismo explica las situaciones conocidas como **“secuestro emocional”**, en las que el sujeto reacciona de forma impulsiva o intensa antes de poder reflexionar sobre lo que ocurre.

Para el AT, comprender este funcionamiento resulta clave para leer conductas explosivas, reacciones de pánico, retraimiento o agresividad como respuestas neuroemocionales, y no como actos deliberados o desafiantes.

Sistema reticular

Conciencia, alerta y regulación del estado vigil

El sistema reticular, también denominado **formación reticular**, está constituido por una red de neuronas que se extiende desde el tronco encefálico hacia el tálamo, el hipotálamo y la corteza cerebral, y desciende hacia la médula espinal.

Su función principal es regular el nivel general de activación del sistema nervioso, modulando:

- El estado de conciencia,
- La atención,
- La alerta,
- La transición entre sueño y vigilia.

Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA)

El SARA cumple un rol fundamental en la activación de la corteza cerebral frente a estímulos relevantes del entorno. Gracias a este sistema, el sujeto puede mantenerse despierto, atento y disponible para el contacto con el otro.

Alteraciones en el funcionamiento del sistema reticular pueden manifestarse como:

- Hiperalerta,
- Somnolencia excesiva,
- Dificultades atencionales,
- Desorganización conductual,

- Baja disponibilidad vincular.

Estas manifestaciones son frecuentes en contextos de padecimiento psíquico, trauma, consumo problemático o desregulación emocional severa.

Articulación entre sistema límbico y sistema reticular

El sistema límbico y el sistema reticular interactúan de manera permanente:

- El sistema límbico aporta la carga emocional de la experiencia,
- El sistema reticular regula el nivel de conciencia necesario para procesarla.

Esta articulación explica por qué emociones intensas afectan directamente la atención, el sueño, la vigilia y la capacidad de regulación conductual. Estados de miedo, angustia o excitación emocional pueden generar hiperactivación o bloqueo, impactando en la posibilidad de vínculo.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Para el Acompañante Terapéutico, el conocimiento de estos sistemas permite:

- Comprender reacciones emocionales intensas sin reducirlas a la voluntad del sujeto,
- Identificar estados de hiperactivación o desconexión,
- Acompañar procesos de regulación emocional y atencional,
- Sostener intervenciones que favorezcan la disponibilidad vincular.

Desde esta perspectiva, el acompañamiento se orienta a crear condiciones de seguridad, previsibilidad y regulación que permitan al sujeto restablecer un equilibrio emocional y relacional.

Sistema Nervioso Autónomo y Sistema Endocrino

Regulación involuntaria, estrés y equilibrio cuerpo–emoción–conducta

El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y el sistema endocrino constituyen los principales sistemas de regulación involuntaria del organismo. Ambos actúan de manera coordinada para mantener el equilibrio interno (homeostasis) y permitir la adaptación del sujeto a las demandas del entorno, especialmente frente a situaciones de estrés, amenaza o cambio.

Desde una perspectiva clínica, estos sistemas explican por qué los estados emocionales tienen manifestaciones corporales concretas y por qué el cuerpo se convierte en un escenario privilegiado del malestar psíquico.

Sistema Nervioso Autónomo (SNA)

El Sistema Nervioso Autónomo regula funciones que no dependen del control consciente, tales como:

- La frecuencia cardíaca,
- La respiración,
- La digestión,
- La presión arterial,
- La sudoración,
- La actividad glandular.

Su acción es rápida y directa sobre órganos y tejidos, permitiendo respuestas inmediatas frente a los cambios del entorno.

División funcional del SNA

El SNA se divide en dos ramas que actúan de manera complementaria:

Sistema simpático

El sistema simpático prepara al organismo para la acción ante situaciones de exigencia, peligro o estrés. Se asocia a la respuesta conocida como “lucha o huida”.

Entre sus principales efectos se encuentran:

- Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial,
- Dilatación bronquial,
- Aumento del estado de alerta,
- Inhibición de la digestión,
- Liberación de glucosa para disponer de energía inmediata.

Este sistema resulta indispensable para la supervivencia, pero su activación sostenida en el tiempo puede generar desgaste físico y emocional.

Sistema parasimpático

El sistema parasimpático favorece el descanso, la recuperación y la conservación de energía. Predomina en situaciones de calma y seguridad.

Entre sus efectos principales se destacan:

- Disminución de la frecuencia cardíaca,
- Estimulación de la digestión,
- Relajación muscular,
- Favorecimiento del sueño y del reposo,
- Restauración del equilibrio corporal.

Este sistema cumple un rol central en los procesos de regulación emocional y recuperación del organismo luego de situaciones de estrés.

Equilibrio autonómico

La mayoría de los órganos del cuerpo reciben inervación simpática y parasimpática. Estas dos ramas no funcionan como opuestas, sino como sistemas complementarios que ajustan el funcionamiento del organismo según las necesidades del momento.

El **hipotálamo** cumple un rol central en la regulación del SNA, ya que integra información proveniente del cuerpo, del entorno y de las emociones, manteniendo el equilibrio entre activación y reposo.

La desregulación de este equilibrio se observa clínicamente en:

- Cuadros de ansiedad,
- Estrés crónico,
- Trastornos del sueño,
- Síntomas psicosomáticos,
- Estados de hiperactivación o agotamiento.

Sistema endocrino

Regulación hormonal y temporalidad de las respuestas

El sistema endocrino está constituido por un conjunto de glándulas distribuidas en el organismo que secretan hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que

viajan a través del torrente sanguíneo y actúan sobre órganos y tejidos específicos, regulando procesos de mediano y largo plazo.

Entre las funciones reguladas por el sistema endocrino se encuentran:

- El crecimiento y desarrollo,
- El metabolismo,
- Los ritmos biológicos (sueño–vigilia),
- La respuesta al estrés,
- La regulación emocional.

A diferencia del sistema nervioso, cuya acción es rápida y puntual, el sistema endocrino produce efectos más lentos pero sostenidos en el tiempo.

Hipotálamo e hipófisis: eje de integración

La **hipófisis** es considerada la glándula central del sistema endocrino, ya que regula la actividad de otras glándulas (tiroides, suprarrenales, gónadas, entre otras) mediante mecanismos de retroalimentación (feedback).

Sin embargo, la hipófisis se encuentra bajo el control del **hipotálamo**, estructura que articula el sistema nervioso con el sistema endocrino. Esta relación evidencia la profunda integración entre ambos sistemas y explica cómo las emociones, el estrés y las experiencias vitales pueden producir modificaciones hormonales.

Un ejemplo claro de esta articulación es la respuesta al estrés:

- El sistema nervioso activa respuestas inmediatas,
- El sistema endocrino libera hormonas como la adrenalina y el cortisol, que prolongan y modulan la respuesta.

Integración cuerpo, emoción y conducta

La articulación entre el Sistema Nervioso Autónomo y el sistema endocrino explica por qué los estados emocionales se expresan corporalmente a través de:

- Alteraciones del sueño y del descanso,
- Cambios en el apetito,
- Fatiga o hiperactivación,
- Modificaciones del estado de ánimo,

- Síntomas somáticos.

Desde esta perspectiva, el cuerpo no es un mero soporte biológico, sino un espacio donde se inscriben las experiencias emocionales y vinculares.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Para el Acompañante Terapéutico, comprender la regulación neuroendocrina resulta fundamental para:

- Interpretar reacciones corporales sin reducirlas a la voluntad del sujeto,
- Reconocer señales de desregulación emocional y fisiológica,
- Acompañar procesos de regulación, estabilidad y cuidado,
- Sostener intervenciones que favorezcan el equilibrio entre activación y reposo.

Este enfoque permite leer la conducta como expresión de una compleja articulación entre cuerpo, emoción, historia y contexto, eje central de una práctica ética y clínica del Acompañamiento Terapéutico.

Sueño y descanso

Regulación neurobiológica, salud mental y acompañamiento terapéutico

El sueño y el descanso constituyen funciones biológicas esenciales para la salud física, emocional y psíquica del ser humano. Lejos de ser un estado pasivo, el sueño es un proceso activo y altamente organizado que cumple un rol central en la regulación del sistema nervioso, la consolidación de la memoria, el procesamiento emocional y la estabilidad del funcionamiento psíquico.

Desde una perspectiva clínica, los trastornos del sueño suelen ser uno de los primeros indicadores de malestar subjetivo y de desregulación emocional, por lo que su observación resulta especialmente relevante en el trabajo del Acompañante Terapéutico.

Arquitectura del sueño

El sueño se organiza en ciclos que se repiten varias veces a lo largo de la noche. Cada ciclo incluye diferentes fases que cumplen funciones específicas en el equilibrio del organismo.

Sueño No MOR (No REM)

Durante el sueño No MOR predominan los procesos de descanso y recuperación corporal. Se caracteriza por:

- Disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria,
- Relajación muscular,
- Descenso de la presión arterial,
- Predominio de la actividad parasimpática.

En esta fase, el organismo recupera energía, repara tejidos y restablece el equilibrio fisiológico. El sueño profundo No MOR es especialmente importante para la restauración física y la sensación de descanso reparador.

Sueño MOR (REM)

El sueño MOR se caracteriza por una intensa actividad cerebral, similar a la vigilia, y es la fase en la que se producen la mayoría de los sueños.

Durante esta etapa se observa:

- Aumento de la actividad cerebral,
- Activación del sistema simpático,
- Irregularidad en la frecuencia cardíaca y respiratoria,
- Atonía muscular (parálisis fisiológica).

El sueño MOR cumple un rol central en el procesamiento emocional, la consolidación de la memoria y la integración de experiencias vividas durante el día.

Regulación neurobiológica del sueño

El sueño está regulado por una compleja interacción entre estructuras cerebrales, neurotransmisores y sistemas hormonales. El hipotálamo, el tronco encefálico y el sistema reticular participan activamente en la regulación del ciclo sueño–vigilia.

Asimismo, el sistema endocrino interviene a través de la secreción de hormonas como la melatonina, que regula los ritmos circadianos, y el cortisol, cuya alteración se asocia a trastornos del sueño vinculados al estrés y la ansiedad.

Esta regulación explica por qué los estados emocionales, el estrés crónico y las experiencias traumáticas impactan directamente en la calidad y cantidad del sueño.

Consecuencias de la privación del sueño

La falta de sueño o un descanso de mala calidad tiene efectos significativos sobre la salud integral del sujeto. Diversas investigaciones han demostrado que la privación del sueño se asocia a:

- Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares,
- Alteraciones metabólicas, incluyendo obesidad y diabetes,
- Disminución de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas,
- Irritabilidad, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo,
- Mayor vulnerabilidad al estrés y menor capacidad de regulación emocional.

En sujetos con padecimientos mentales, consumos problemáticos o situaciones de vulnerabilidad psicosocial, la alteración del sueño suele intensificar los síntomas y dificultar los procesos terapéuticos.

Sueño, subjetividad y vida cotidiana

El modo en que una persona duerme no puede comprenderse únicamente desde lo biológico. Los hábitos de sueño están atravesados por:

- Condiciones de vida,
- Rutinas cotidianas,
- Contextos familiares e institucionales,
- Experiencias de seguridad o amenaza,
- Niveles de estrés y exigencia.

Desde esta perspectiva, el sueño se constituye como un indicador privilegiado del modo en que el sujeto habita su vida cotidiana y procesa sus experiencias emocionales.

Relevancia para el Acompañamiento Terapéutico

Para el Acompañante Terapéutico, el sueño y el descanso constituyen ejes clínicos fundamentales de observación e intervención indirecta. El AT no prescribe tratamientos médicos, pero puede:

- Registrar cambios en los patrones de sueño,
- Acompañar la construcción de rutinas que favorezcan el descanso,
- Colaborar en la organización del tiempo cotidiano,
- Detectar señales de desregulación que requieran articulación con el equipo tratante.

El acompañamiento orientado al cuidado del descanso contribuye a mejorar la estabilidad emocional, la capacidad de simbolización y la disposición subjetiva para el trabajo terapéutico.

El sueño no es un fenómeno accesorio, sino una función estructurante del equilibrio psíquico y corporal. Comprender su regulación y su impacto en la subjetividad permite al Acompañante Terapéutico intervenir desde una mirada integral, respetuosa de los tiempos del sujeto y atenta a las señales del cuerpo como expresión del malestar psíquico.

Referencias Bibliográficas

- Apuntes: Herencia Mendeliana UNIDAD 5 (se adjunta)
- Pollini, A., & Estenssoro, S. (2025). EPIGENÉTICA, SISTEMA NERVIOSO Y MEDIO AMBIENTE. *SINOPSIS–Revista de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA)*, 20.
- Sanz, M. M. (2015). Epigenética y trastornos psiquiátricos. *Pediatría integral*, *19*(8), 524-531.
- Kandel, E. R., Schwartz & Jessel T. M. (2001). Principios de neurociencia. McGraw-Hill/ Interamericana. Madrid.
- Kolb, B., & Fantie, B. D. (2009). Development of the child's brain and behavior. In Cecil R Reynolds & Elaine Fletcher-Janzen. Handbook of clinical child neuropsychology (pp. 19-46). Springer, Boston, MA.

Palabras finales.

Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso en este camino que no promete comodidades, pero sí sentido. Como Don Quijote, eliges una senda que no es la más ancha ni la más sencilla, sino aquella donde el compromiso con el otro se vuelve ética y la presencia se transforma en acto terapéutico.

Ser Acompañante Terapéutico en la Argentina —y en Jujuy en particular— implica asumir una práctica situada, atravesada por la historia, por las leyes que nos amparan y por las realidades concretas de las personas y comunidades con las que trabajamos. Implica sostener al otro allí donde el lazo se ha debilitado, donde el sufrimiento irrumpe en la vida cotidiana y donde aún persiste el deseo de vivir mejor.

Esta cartilla no es un manual cerrado ni un mapa definitivo. Es, apenas, una hoja de ruta inicial. El verdadero camino se construirá en la formación, en el vínculo, en la práctica supervisada y en la pregunta constante por el sentido de lo que hacemos.

Que este inicio te encuentre dispuesto o dispuesta a aprender, a cuestionar, a comprometerse y a no mirar hacia otro lado frente al dolor del semejante. Porque, como en toda empresa quijotesca, no se trata de vencer gigantes, sino de **no renunciar a lo humano**.

Bienvenido/a al camino del Acompañamiento Terapéutico en el IES 11.